



UNITÉ PÉDAGOGIQUE

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

*« Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer
des soins humanisés de qualité. »*



**L1
TC**

**SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN
INFIRMIER, INFIRMIÈRE**

2025 - 2026

TABLE DES MATIERES

PUBERTE FEMININE	P5
PUBERTE MASCULINE	P8
CYCLE MENSTRUEL NORMAL	P10
GAMETOGENESE	P15
DE LA FECONDATION AU DEVELOPPEMENT DE L'ŒUF	P20
MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES DE L'ORGANISME MATERNEL AU COURS DE LA GROSSESSE	P23
DIAGNOSTIC DE LA GROSSESSE AU DEBUT	P26
CONSULTATION PRENATALE	P28
PRESENTATIONS FŒTALES	P32
MECANISME GENERAL DE L'ACCOUCHEMENT	P36
DELIVRANCE NORMALE	P42
SUITES DE COUCHES NORMALES	P45
HYGIENE DE VIE FEMME ENCEINTE	P49
LES ANNEXES DU FŒTUS	P55
ADMISSION DE LA PARTURIENTE	P59

PUBERTE FEMININE

INTRODUCTION

La puberté est une étape où les transformations de l'organisme seront déterminantes pour la vie de l'individu.

OBJECTIF GENERAL

Etre capable d'expliquer les principaux stades de développement de la puberté.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1) Définir la puberté
- 2) Indiquer le moyen de datation de la puberté féminine
- 3) Citer les différentes modifications physiques qui se produisent pendant la puberté
- 4) Citer les anomalies de la puberté

I. DEFINITION

La puberté est la période d'acquisition des facultés de reproduction. Elle correspond à la période de passage de l'enfance à l'adulte.

II. PHYSIOLOGIE

Le début de la puberté est marqué par une élévation du taux des gonadotrophines (FSH et LH) et des stéroïdes (œstrogènes et progestérone) avec la survenue des premières règles encore appelées ménarches.

Les premières règles sont physiologiquement irrégulières pendant les deux premières années en rapport avec une absence d'ovulation. Elles apparaissent en moyenne à 13ans, avec des extrêmes allant de 9 ans à 14 ans (95% des filles).

III. ETUDE CLINIQUE

L'étude clinique concerne les modifications physiques et psychologiques.

Les caractères sexuels sont représentés par les seins et les poils. Leur développement est classé en cinq (5) stades selon Tanner (voir photo 1)

III.1 Caractères sexuels secondaires

III.1.1 Développement mammaire

Dans la plupart des cas, il est le premier à se manifester sous forme d'une surélévation du mamelon par petite glande uni ou bilatérale. En moyenne, cet événement se produit vers 11 ans, avec des extrêmes allant de 8 ans à 13 ans.

III.1.2 Développement de la pilosité pubienne

Il suit de près l'apparition du développement mammaire, puisqu'il apparaît en moyenne à 11 ans et demi avec des extrêmes allant de 9ans à 14 ans. Il peut être le premier signe pubertaire, précédant l'apparition du développement mammaire dans 16% des cas environ.

III.1.3 La pilosité axillaire :

Elle apparaît à l'âge de 11 à 13ans

III.2 Autres manifestations

- La maturation de l'appareil reproducteur : correspond au développement des organes génitaux, en particulier les grandes lèvres associées à l'apparition des petites lèvres et l'augmentation du volume du clitoris, qui sont plus colorées avec un aspect rosé et humide de la muqueuse vaginale. L'utérus et l'ovaire augmentent de volume.

- L'acquisition de la taille définitive. Elle se fait généralement vers l'âge de 16 ans
 - L'acquisition de la morphologie générale : bassin plus large que les épaules car il y a une accumulation de graisse au niveau de la hanche et une augmentation du diamètre bi trochantérien suivi d'une prise de poids fréquente.
 - L'acquisition de la fonction de reproduction
 - Modifications psychologiques : Les changements peuvent varier énormément d'une personne à l'autre. Les plus fréquents sont : L'anxiété et l'inquiétude suscitées par les modifications ; L'émotion et l'instabilité de l'humeur.
- Pendant cette période la jeune fille développe son individualité et sa personnalité. Elle a envie de liberté et d'indépendance ; ce qui entraîne quelques fois des désaccords et des conflits avec les parents. Pendant la puberté elle ressent un énorme besoin d'apparence. En général elle s'éloigne plus ou moins de ses parents pour se tourner vers des groupes de jeunes de son âge. Enfin, l'attribution sexuelle et l'envie d'avoir une relation stable peuvent prendre de l'importance vers la fin de la période pubertaire.

IV. ANOMALIES DE L'APUBERTÉ

On distingue deux types d'anomalies de la puberté : La puberté précoce et la puberté tardive.

IV.1 Puberté précoce

C'est l'apparition des caractères sexuels secondaires ou signes pubertaires (seins pilosité, menstruation) chez la petite fille avant l'âge de 8 ans.

Elle peut être due à une perturbation neurologique et hormonale, à des conditions nutritionnelles favorables après une malnutrition ou au bien être psychologique et affectif.

La prise en charge des pubertés précoces est fonction de l'étiologie.

IV.2 Puberté tardive

Elle est caractérisée par l'absence de signes pubertaires au-delà de 18 ans. Les étiologies sont nombreuses.

On distingue :

- Les affections chroniques tel que la malnutrition, les cardiopathies sévères, les néphropathies chroniques, les corticothérapies au long cours.
- Une insuffisance isolée en hormone de croissance (GH).
- Une insuffisance thyroïdienne. Les causes hypothalamo-hypophysaires (tumeurs congénitales, lésions cérébrales) une carence affective majeure ou une malnutrition sévère. Elle peut être d'ordre familial.

RESUME

La puberté est la période d'acquisition des facultés de reproduction. Pendant cette période, plusieurs modifications interviennent au niveau des caractères sexuels secondaires ainsi qu'au niveau psychologique. L'on note cependant les pubertés précoces et les pubertés tardives.

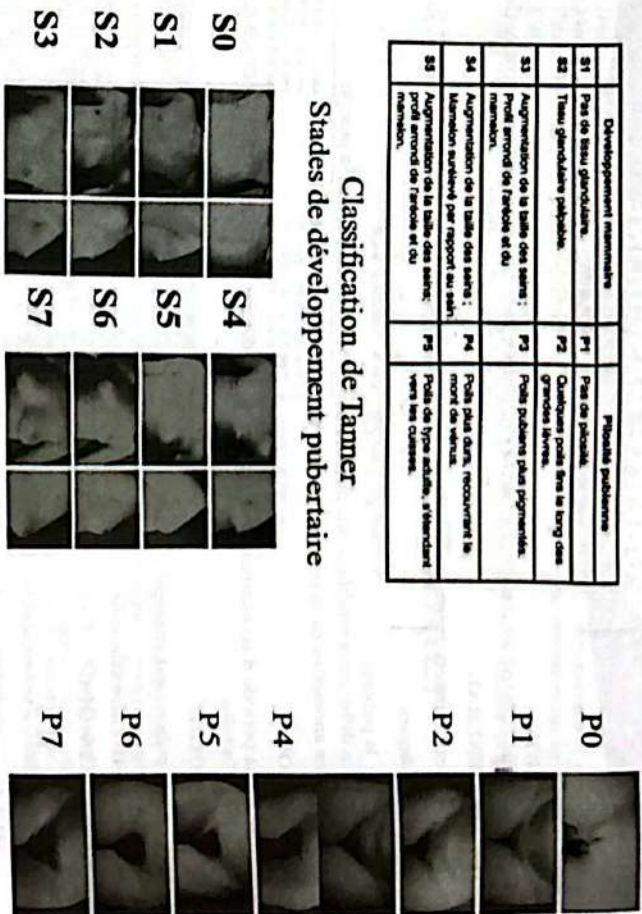


Schéma 1: Classification des caractères sexuels secondaires selon Tanner

INTRODUCTION

La puberté est une étape où les transformations de l'organisme seront déterminantes pour la vie de l'individu.

OBJECTIF GENERAL

Être capable d'expliquer les principaux stades de développement de la puberté.

Objectifs spécifiques

- 1) Définir la puberté
- 2) Citer les différentes modifications physiques qui se produisent pendant la puberté
- 3) Citer les anomalies de la puberté sans se tromper.

I. DEFINITION

La puberté est la période d'acquisition des facultés de reproduction. Elle correspond à la période de passage de l'enfance à l'adulte.

II. PHYSIOLOGIE

Le début de la puberté est marqué par une élévation du taux des gonadotrophines (FSH et LH) et des stéroïdes (androgènes) avec l'apparition des pollutions nocturnes (sperme). Elle survient en moyenne à 13 ans, avec des extrêmes allant de 9 ans à 14 ans (95% des garçons).

III. ETUDE CLINIQUE

Concerne les modifications physiques et psychologiques. Les caractères sexuels sont représentés par l'augmentation du volume testiculaire, de la verge et l'apparition des poils.

III.1 Caractères sexuels secondaires

- La pilosité pubienne apparaît en moyenne 6 mois après le début du développement testiculaire. La pilosité faciale est encore plus tardive, de même que la pilosité corporelle.
- La modification de la voix.
- La moustache et la barbe apparaissent plus tard
- La sudation corporelle se modifie
- Apparition de l'acné
- Chez 30 à 65% des garçons apparaît en milieu de puberté une gynécomastie bilatérale qui régressera en quelques mois dans la quasi-totalité des cas.

La croissance pubertaire démarre vers 13 ans. La taille finale est atteinte autour de 18 ans.

III.2 Développement des organes génitaux

- Les testicules

Le premier signe de puberté est l'augmentation de volume testiculaire vers l'âge de 11,5 ans. Cette augmentation est physiologique entre 9,5 ans et 14 ans. Le volume testiculaire devient > 4 ml ou si on mesure la plus grande longueur, celle-ci atteint ou dépasse 2,5 cm

- La verge

L'augmentation de la taille de la verge débute vers l'âge de 12,5 ans.

III.3 Autres manifestations

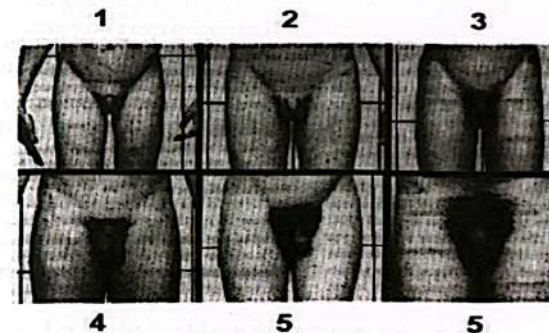
- La maturation de l'appareil reproducteur (Développement des caractères sexuels primaires que sont les organes génitaux.
- L'acquisition de la taille définitive

- L'acquisition de la morphologie générale (diamètre bi-acromial supérieur au diamètre bi trochantérien suivi d'une prise de poids fréquente.)
- L'acquisition de la fonction de reproduction
- Modifications psychologiques (Les changements peuvent varier énormément d'une personne à l'autre. Parmi eux les plus fréquents sont : L'anxiété et l'inquiétude suscitées par les modifications ; L'émotion et l'instabilité de l'humeur.)

Pendant cette période le jeune garçon développe (comme la jeune fille) son individualité et sa personnalité.

Classification de Tanner chez le garçon

• G2 11.6 ± 1.1 mm	• P2 13.4 ± 1.1 mm
• G3 12.9 ± 1.1 mm	• P3 13.9 ± 1.0 mm
• G4 13.8 ± 1.0 mm	• P4 14.4 ± 1.1 mm
• G5 14.9 ± 1.1 mm	• P5 15.2 ± 1.1 mm



G1: Infantile

G2: 25-30 mm (4-6 ml)

G3: 30-40 mm (6-12ml),
croissance verge

G4: 40-50 mm (12-16ml)

G5: adulte

Schéma 2 : Classification des caractères sexuels secondaires selon Tanner

OBJECTIF GENERAL

Être capable de connaître le cycle menstruel.

Objectifs spécifiques

- 1) Définir le cycle menstruel,
- 2) Décrire les différentes phases du cycle menstruel,
- 3) Identifier les différents organes qui interviennent dans la régulation du cycle menstruel.

I. GENERALITES

I.1 Définitions

I.1.1 Cycle menstruel

Le cycle menstruel (CM) est la période qui s'étend du 1^{er} jour des règles au dernier jour précédent les prochaines règles. Il dure en moyenne 28 jours pour environ 60% des femmes. Environ 35 % des femmes ont un cycle de 28 +/- 4 jours ; il s'agit encore d'un cycle régulier.

- Cycle court < 25 jours
- Cycle long > 35 jours.

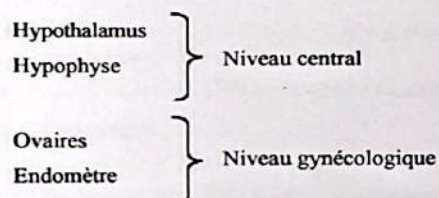
I.1.2 La durée des règles

Les règles durent en moyenne 4 à 5 jours.

NB : Le CM se déroule de la puberté (12 à 13 ans) à la ménopause (50 ans). Le cycle est interrompu par la grossesse.

I.2 Eléments intervenant dans le cycle mensuel

Quatre (4) éléments interviennent dans le cycle mensuel qui sont :



II. PHYSIOLOGIE DU CM

Le CM se caractérise par une succession de quatre phases pendant lesquelles apparaissent des modifications morphologiques, fonctionnelles et sécrétoires des organes génitaux de la femme qui sont :

- ✓ Les ovaires → cycle ovarien,
- ✓ L'utérus → cycle endométrial,
- ✓ Organes périphériques : vagin, seins. Les trois (3) phases du CM (de 28 jours) sont :
 - La phase folliculaire ou oestrogénique ou proliférative du début des règles à J13.
 - La phase ovulatoire qui survient à J14.
 - La phase lutéale ou sécrétoire ou oestro-progestative

III. DEROULEMENT DUCYCLE

❖ La phase folliculaire

Au niveau de l'ovaire, L'ovaire a une double fonction : **exocrine** aboutissant à l'ovulation et **endocrine** par la sécrétion d'hormones stéroïdes.

Pendant la phase folliculaire, les follicules primordiaux croissent. Un seul arrive à maturité pour donner le **follicule de DEGRAAF (ou follicule mûr)**.

Les œstrogènes sont sécrétés au niveau de la thèque interne du follicule. Le pic de sécrétion est atteint à J13 du cycle et décroît le jour de l'ovulation.

Au niveau de l'utérus, Les œstrogènes sécrétés par le follicule mûr entraînent des phénomènes prolifératifs au niveau de l'endomètre (Epaississement de la couche superficielle, augmentation du nombre et du volume des tubes glandulaires etc.), et sécrétion de la glaire au niveau du col.

❖ La phase ovulatoire

Au niveau de l'ovaire, la ponte ovulaire a lieu par rupture du follicule mur et expulsion de l'ovocyte au 14^{ème} jour du cycle.

Au niveau de l'utérus, l'endomètre est prolifératif, la glaire cervicale est abondante, filante atteignant sa sécrétion maximale.

La température est supérieure à 37°C.

❖ La phase lutéale

Au niveau de l'ovaire, après la rupture folliculaire et la ponte de l'ovule, ce qui reste du follicule de DEGRAAF se transforme en corps jaune responsable de la sécrétion de stéroïdes (œstrogènes, progestérone). La progestérone atteint un plateau sécrétoire au 17^{ème} jour et se maintient jusqu'au 26^{ème} jour. En l'absence de fécondation, le corps jaune s'atrophie et se transforme en corps albicans. La sécrétion de stéroïdes cesse et cette chute brutale du taux d'hormone entraîne la survenue des règles 24h à 48h plus-tard. Si l'ovule est fécondé on a le corps jaune gestatif qui permet le maintien premier de la grossesse.

Au niveau de l'utérus, la muqueuse utérine subit des transformations pour donner la dentelle utérine apte à une éventuelle nidation :

- Epaississement de l'endomètre
- Les cellules glandulaires se chargent en glycogène
- Les glandes endométriales deviennent tortueuses
- Les artérioles spiralées irrigant l'endomètre s'individualisent
- Le chorion devient très oedématisé
- Au niveau de l'utérus, on observe une nécrose des parois vasculaires liée à la chute brutale de la sécrétion de progestérone et d'œstrogène (atrophie du corps jaune). Il s'ensuit une élimination de la couche superficielle de l'endomètre avec écoulement menstruel. Cet écoulement est composé de sang et de muqueuse utérine desquamée. Il survient 14 jours après l'ovulation.

IV. REGULATION DU CYCLEMENSTRUEL

Elle fait intervenir :

- Le système nerveux central (SNC)
- Le système hypothalamo-hypophysaire
- Les ovaires par la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone

NB : La FSH (Hormone folliculo-stimulante) permet la maturation folliculaire.

La LH (hormone lutéinisante) assure la transformation du follicule en corps jaune et le maintien de ce corps jaune.

L'hypothalamus sécrète la Gn-RH (gonadolibérine) ou LH-RH.
 La Gn-RH (gonadolibérine) ou LH-RH stimule l'hypophyse antérieure qui va à son tour, libérer des gonadotrophines (FSH et LH).
 Les gonadotrophines (FSH et LH) vont induire la croissance et la maturation folliculaire.
 Ces follicules ovariens vont sécréter les œstrogènes et la progestérone.
 Les œstrogènes et la progestérone vont entraîner la prolifération de l'endomètre (dénutrition).
 Il existe deux types de régulation : Le rétrocontrôle positif et Le rétrocontrôle négatif.
Le rétrocontrôle positif : c'est l'augmentation des sécrétions hormonales du niveau central (GnRH) consécutive à la baisse des sécrétions hormonales du niveau central (GnRH) consécutive à l'augmentation des sécrétions hormonales ovariennes.
Le rétrocontrôle négatif : c'est la baisse des sécrétions hormonales du niveau central (GnRH) consécutive à l'augmentation des sécrétions hormonales ovariennes.

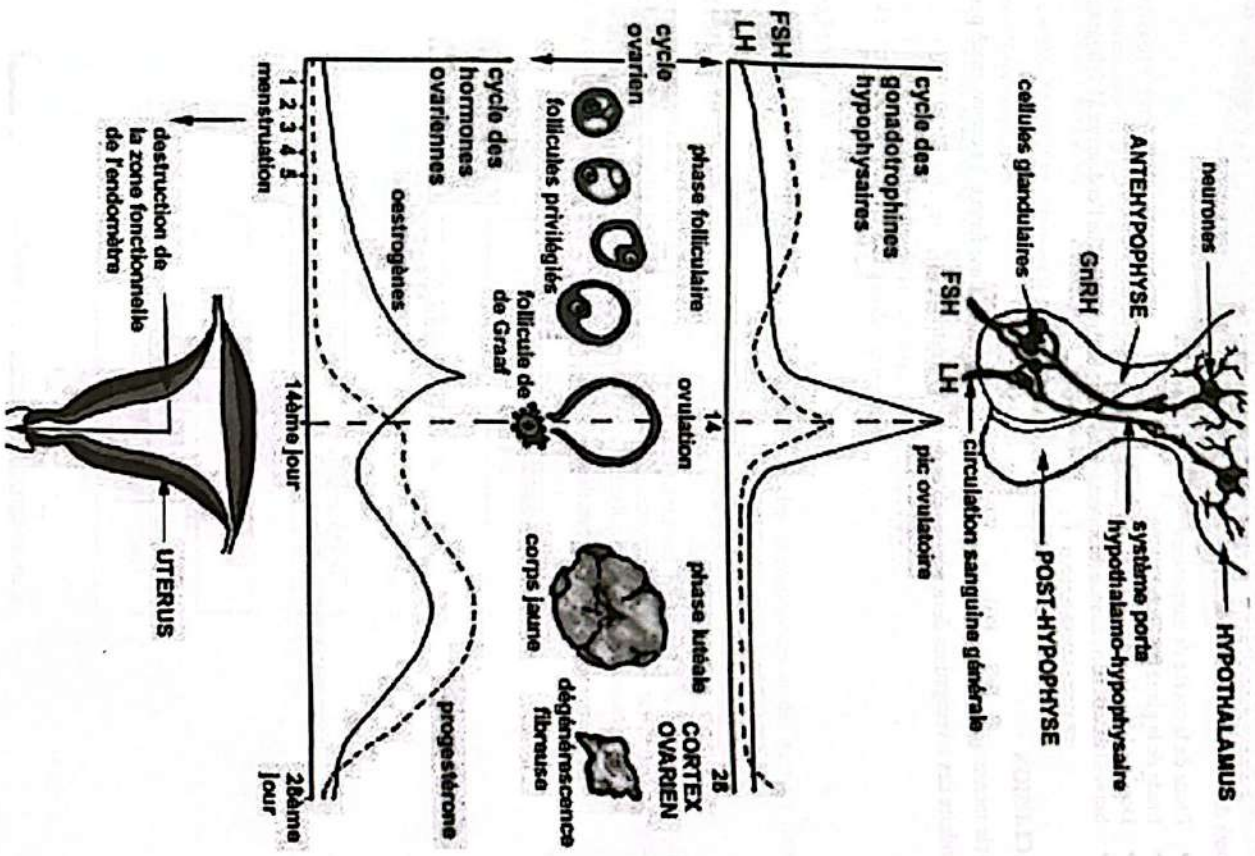
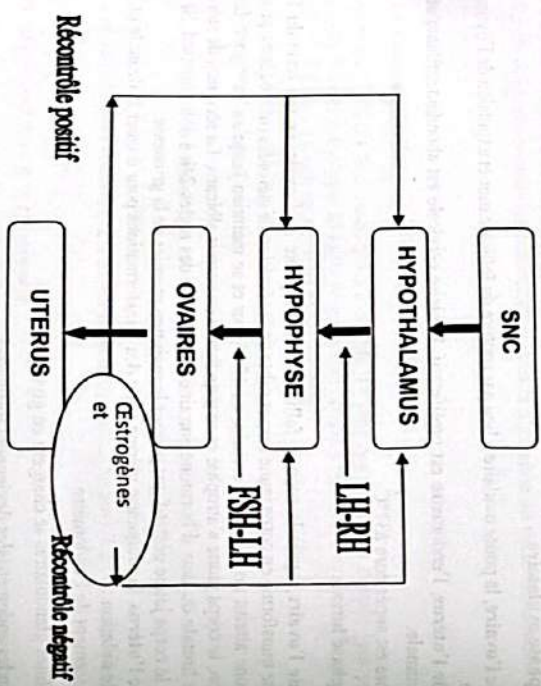


Schéma 3: Cycle menstruel et sa régulation

V. EXPLORATIONS DU CYCLE MENSTRUEL

Au cours du CM différents examens peuvent être réalisés :

- Etude de la courbe de température
- Etude de la glaire cervicale
- Dosages hormonaux : FSH, LH, progestérone, oestradiol
- Surveillance de la croissance (monitorage) des follicules ovariens et de l'endomètre à l'échographie.

CONCLUSION

Le cycle menstruel occupe une place importante dans la vie génitale d'une femme. Sa connaissance permet de conduire des investigations devant les troubles du cycle menstruel.

GAMETOGENESE

INTRODUCTION

La connaissance de la gamétogenèse est indispensable à la compréhension de la reproduction.

OBJECTIF GENERAL

Être capable de connaître le processus de formation des gamètes mâles et femelles.

Objectifs spécifiques

- 1) Définir la gamétogenèse,
- 2) Citez les stades de développement folliculaire,
- 3) Enumérer les différentes étapes de la spermatogenèse.
- 4) Enumérer les différentes étapes de l'ovogenèse

I. DEFINITION

La gamétogenèse est la production des gamètes mâles appelés spermatozoïdes et des gamètes femelles appelés ovules.

II. SPERMATOGENESE

La **spermatogenèse** est le processus de production des spermatozoïdes. Elle a lieu dans les tubes séminifères des testicules. Elle englobe les phénomènes qui, des spermatogonies, cellules souches diploïdes ($2n$ chromosomes), aboutissent aux spermatozoïdes, gamètes mâles haploïdes (n chromosomes).

En fait, les cellules non différenciées se développent pour finalement devenir des gamètes mâles :

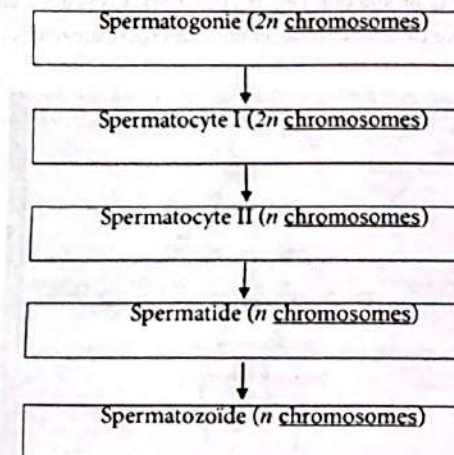


Schéma 4 : processus de la spermatogenèse

❖ Explication du schéma

Les spermatogonies se divisent pour donner des spermatocytes primaires (I). Les **spermatocytes primaires (I)** nouvellement formés subissent alors une première division méiotique. Ils entament une deuxième division avec une prophase longue de 24 jours. A cette prophase font suite rapidement une métaphase, une anaphase et une télophase.

Chaque spermatocyte primaire donne **deux spermatocytes secondaires (II)**. Les **spermatocytes secondaires (II)** abordent directement la deuxième division méiotique dont sont issus les spermatides. La division des chromatides d'un spermatocyte secondaire donne naissance à **deux spermatides haploïdes** qui ne possèdent plus que la moitié du contenu en ADN.

Les **spermatides** vont progressivement se différencier en spermatozoïdes mature.

Régulation hormonale

Trois hormones jouent un rôle important lors de la spermatogenèse :

- **La testostérone**
- **LH** (hormone lutéinisante)
- **FSH** (hormone folliculo stimulante)

LH et FSH sont produites par l'hypophyse tandis que la testostérone est produite dans les cellules de Leydig (Testicule).

La FSH agit directement sur les spermatogonies et les cellules de Sertoli pour accélérer la spermatogenèse (par assimilation augmentée de testostérone). La LH, quant à elle, augmente la production de testostérone qui agit également sur les spermatogonies (et permet en particulier la différenciation finale) et sur les cellules de Sertoli. Si la production de testostérone atteint un certain seuil, les cellules de Leydig envoient un rétrocontrôle négatif à l'hypophyse qui inhibe la production de LH et de FSH. C'est donc un système autorégulé qui ne permet pas la production excessive de testostérone, et donc des spermatozoïdes

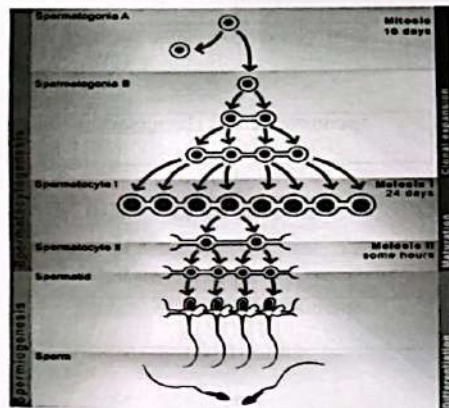


Schéma 5: Schéma général de la spermatogenèse.

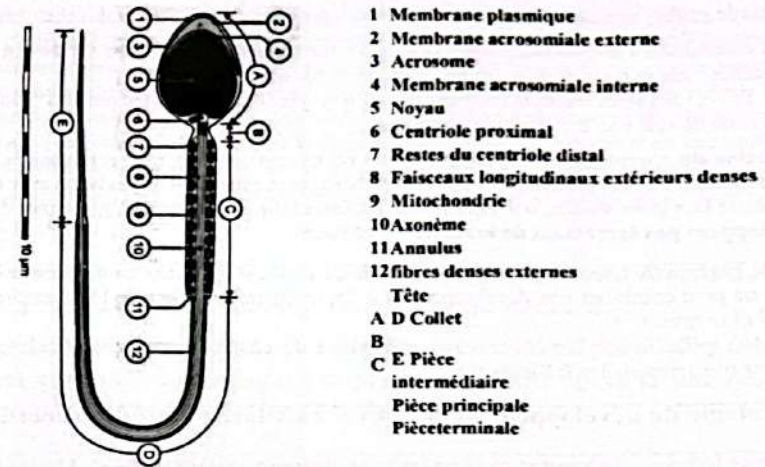


Schéma 6 : Le spermatozoïde mature

II. OVOGENESE

Elle fait intervenir la différenciation des cellules germinales primordiales (ovogonies), leur développement en ovocytes dans les follicules jusqu'au stade final de l'ovulation. L'évolution des différents stades folliculaires est indissociable de l'ovogenèse.

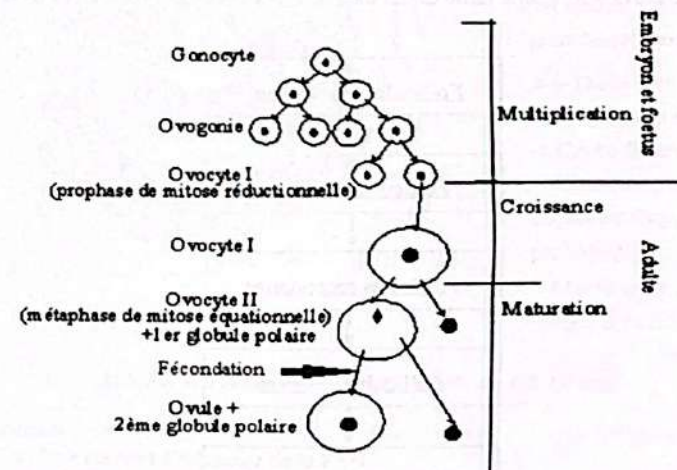


Schéma 7 : Processus de l'ovogenèse

Durant la période embryonnaire et fœtale les ovogonies prolifèrent pour donner des ovocytes I.

Les ovocytes I commencent leur multiplication et sont bloqués à la prophase I. A partir de la puberté l'ovocyte I se différencie et termine sa première division méiotique.

A l'ovulation, l'ovocyte I se différencie pour aboutir à l'ovocyte II avec l'élimination du 1^{er} globule polaire. Cet ovocyte II reste bloqué à la 2^{ème} division méiotique.

Dès la pénétration du spermatozoïde fécondant dans cet ovocyte II, il reprend et termine la 2^{ème} division mitotique aboutissant à l'ovocyte mûr prêt pour enclencher le processus de la fécondation avec expulsion du 2^{ème} globule polaire. Dès la naissance, il y a donc deux structures différentes qu'il s'agit de bien différencier et qui ne se développent pas forcément de manière synchrone :

- La cellule germinale femelle qui a atteint le stade de l'ovocyte primaire au moment de la naissance, mais qui ne peut continuer son développement qu'après la puberté (lors de l'instauration d'un cycle hormonal et ovarien).
- le follicule (épithélium folliculaire + ovocyte) qui se développe à partir du follicule primordial en passant par plusieurs stades folliculaires.

Chronologie du développement de la CGP : Cellule germinale primordiale

→ovogonie → ovocyte primaire →ovocyte primaire → Ovocyte II (fécondation) →Ovule

Les stades folliculaires : des follicules primordiaux aux follicules tertiaires L'ovaire est divisé en une zone corticale (cortex ovarien) et une zone médullaire (médullaire ovarienne). Les ovocytes se trouvent dans la zone corticale à différents stades folliculaires. A partir du follicule primordial se développe le follicule primaire, secondaire, puis tertiaire. Toutefois, seul un faible pourcentage des follicules primordiaux atteint le stade de follicule tertiaire. La majorité des follicules "s'atrophient" à divers stades avant la fin de la maturation. Les follicules tertiaires sont les plus grands. Ils peuvent atteindre peu avant l'ovulation, suite à une poussée de croissance particulière, une taille de 25 mm et sont alors appelés follicules de Graaf. On a donc successivement :

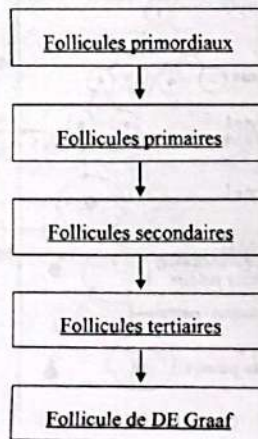


Schéma 8 : Processus de la folliculogénèse

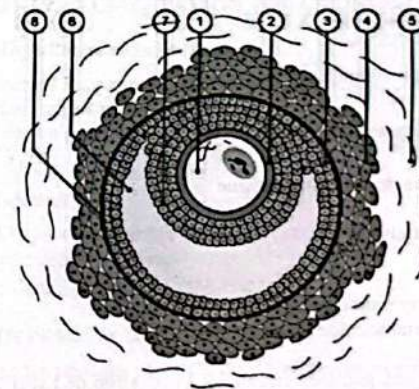
Lorsque les follicules secondaires persistent, ils se transforment en follicules tertiaires. Ils se caractérisent par l'apparition des petites lacunes remplies de liquide dont la confluence forme la cavité folliculaire (antrum) dans la granulosa. Autour de l'ovocyte, la granulosa fait saillie dans la l'antrum constituant le cumulus oophorus ou disque prolifère. L'ovocyte est devenu entre-temps si grand que son noyau a la taille d'un follicule primaire. Le tissu conjonctif autour du follicule s'est déjà différencié en une thèque interne bien vascularisée avec de grandes cellules riches en lipides (production hormonale) et en une thèque externe qui forme la transition avec le stroma de l'ovaire et qui contient les grands vaisseaux.

Le follicule de DEGRAAF correspond à un follicule tertiaire particulièrement grand dont on suppose qu'il arrivera jusqu'à l'ovulation.

Le destin normal d'un follicule ou d'une cellule germinale femelle est l'atréxie. L'ovulation représente un sort exceptionnel pour un follicule.

Il reste environ 400 000 ovocytes et follicules primordiaux par ovaire à la naissance constituant une réserve qui s'épuise progressivement après la naissance pendant l'enfance et pendant la vie génitale de la femme.

Seulement environ 450 arriveront à maturité avec la rupture folliculaire et la libération de l'ovocyte (ovulation).



- 1-Ovocyte/ovule
- 2-Zone pellucide
- 3-Couche granuleuse(granulosa)
- 4-Thèque interne
- 6-Thèque externe
- 7-Cavité folliculaire
- 8-Cumulus oophorus(disque prolifère)
- Membrane basale entre thèque et couche granuleuse

Schéma 9: Follicule tertiaire (follicule de DE Graaf)

Régulation hormonale

La croissance folliculaire est sous l'influence de la FSH.

La ponte ovulaire (ovulation) est sous l'influence du pic de LH

CONCLUSION

La connaissance des différentes étapes de la gamétogenèse permet de mieux comprendre les phénomènes qui régissent la procréation et de comprendre surtout les problèmes de stérilité rencontrés dans le couple.

DE LA FECONDATION AU DEVELOPPEMENT DE L'OEUF

INTRODUCTION

Les différentes étapes allant de la fécondation jusqu'au développement de l'œuf permettent une meilleure compréhension du début de la grossesse.

OBJECTIF GENERAL

Être capable de connaître la physiologie de la fécondation humaine et du développement de l'œuf.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1) Définir la fécondation
- 2) Décrire les étapes clés de la fécondation
- 3) Définir la période embryonnaire
- 4) Définir la période fœtale

I. FECONDATION

I.1 Définition

La fécondation est la fusion de deux gamètes male (spermatozoïde) et femelle (ovocyte).

I.2 Types de fécondation

Il y existe deux types de fécondation qui sont :

- La fécondation in vivo (dans l'organisme vivant)
- La fécondation in vitro (dans un verre)

I.3 Lieu de la fécondation in vivo

La fécondation in vivo a lieu dans le tiers externe de la trompe utérine

I.4 Les étapes clés de la fécondation in vivo

Les étapes clés de la fécondation sont :

- La capacitation ou acquisition de la fécondance du spermatozoïde ;
- La reconnaissance et la fixation du spermatozoïde à la zone pellucide ;
- La réaction acrosomique ;
- La fusion des membranes plasmiques des gamètes entraînant l'activation de l'œuf ; la reprise de la méiose ovocytaire ; la décondensation du noyau spermatique et la formation des pronoyaux ; le développement des pronoyaux.

I.5 Déterminisme du sexe génétique

Le sexe génétique de l'embryon se détermine dès la fécondation.

Si c'est un spermatozoïde porteur de chromosome X qui pénètre dans l'ovocyte II, l'embryon est du sexe génétique XX c'est-à-dire féminin.

Si c'est un spermatozoïde porteur de chromosome Y qui pénètre dans l'ovocyte II, l'embryon est du sexe génétique XY c'est-à-dire masculin.

C'est le sexe masculin qui détermine le sexe de l'enfant.

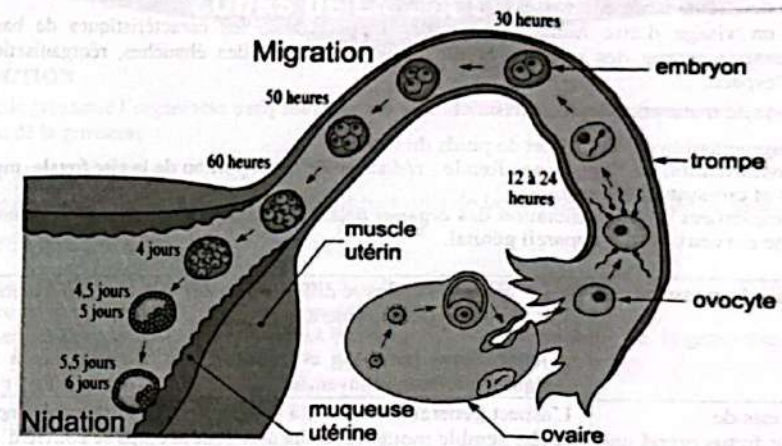


Schéma 10 : Fécondation, migration, segmentation et nidation

II. MIGRATION, SEGMENTATION, NIDATION

II.1 Migration et segmentation

Les deux processus surviennent ensemble dès la fécondation. L'œuf quitte la trompe pour s'acheminer vers la cavité utérine (migration).

Tout au long de son parcours l'œuf se multiplie (segmentation) selon une suite géométrique de raison 2 (2, 4, 8, 16, 32...).

II.2 Nidation

Vers le 5^{ème}, 6^{ème} jour l'œuf arrive dans la cavité utérine, vers le 7^{ème} jour il se fixe à la paroi utérine en pénétrant dans l'endomètre (nidation).

Cette nidation dure 7 jours.

III. DEVELOPPEMENT DE L'OEUF

Il y a deux grandes périodes au cours du développement de l'œuf : la période embryonnaire qui part de la fécondation jusqu'à la 7^{ème} semaine de grossesse, et la période fœtale qui part de la 8^{ème} semaine de grossesse jusqu'à la naissance.

III.1 Période embryonnaire :

- ❖ 1^{ère} semaine de grossesse : phénomène de fécondation, segmentation, migration et formation de blastocyste.
- ❖ 2^{ème} semaine de grossesse : correspond à la nidation pré gastrulation et l'ébauche des annexes internes (bouton embryonnaire)
- ❖ 3^{ème} semaine de grossesse : début du développement du système nerveux et de la circulation placentaire.
- ❖ 4^{ème} semaine de grossesse jusqu'à la 7^{ème} semaine de grossesse : période organogénétique marquée par la différenciation de la plupart des organes : épiderme, tissu nerveux, système digestif, rénal, circulatoire..., fermeture de la paroi abdominale et du tube neural.

DE LA FECONDATION AU DEVELOPPEMENT DE L'OEUF

INTRODUCTION

Les différentes étapes allant de la fécondation jusqu'au développement de l'œuf permettent une meilleure compréhension du début de la grossesse.

OBJECTIF GENERAL

Être capable de connaître la physiologie de la fécondation humaine et du développement de l'œuf.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1) Définir la fécondation
- 2) Décrire les étapes clés de la fécondation
- 3) Définir la période embryonnaire
- 4) Définir la période fœtale

I. FECONDATION

I.1 Définition

La fécondation est la fusion de deux gamètes male (spermatozoïde) et femelle (ovocyte).

I.2 Types de fécondation

Il y a deux types de fécondation qui sont :

- La fécondation in vivo (dans l'organisme vivant)
- La fécondation in vitro (dans un verre)

I.3 Lieu de la fécondation in vivo

La fécondation in vivo a lieu dans le tiers externe de la trompe utérine

I.4 Les étapes clés de la fécondation in vivo

Les étapes clés de la fécondation sont :

- La capacitation ou acquisition de la fécondance du spermatozoïde ;
- La reconnaissance et la fixation du spermatozoïde à la zone pellucide ;
- La réaction acrosomique ;
- La fusion des membranes plasmiques des gamètes entraînant l'activation de l'œuf ; la reprise de la méiose ovocytaire ; la décondensation du noyau spermatique et la formation des pronoyaux ; le développement des pronoyaux.

I.5 Déterminisme du sexe génétique

Le sexe génétique de l'embryon se détermine dès la fécondation.

Si c'est un spermatozoïde porteur de chromosome X qui pénètre dans l'ovocyte II, l'embryon est du sexe génétique XX c'est-à-dire féminin.

Si c'est un spermatozoïde porteur de chromosome Y qui pénètre dans l'ovocyte II, l'embryon est du sexe génétique XY c'est-à-dire masculin.

C'est le sexe masculin qui détermine le sexe de l'enfant.

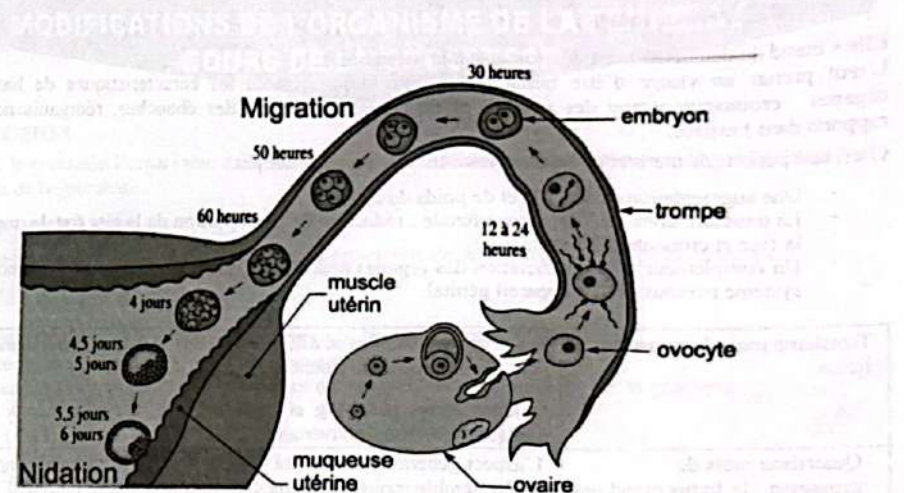


Schéma 10 : Fécondation, migration, segmentation et nidation

II. MIGRATION, SEGMENTATION, NIDATION

II.1 Migration et segmentation

Les deux processus surviennent ensemble dès la fécondation. L'œuf quitte la trompe pour s'acheminer vers la cavité utérine (migration).

Tout au long de son parcours l'œuf se multiplie (segmentation) selon une suite géométrique de raison 2 (2, 4, 8, 16, 32...).

II.2 Nidation

Vers le 5^{ème}, 6^{ème} jour l'œuf arrive dans la cavité utérine, vers le 7^{ème} jour il se fixe à la paroi utérine en pénétrant dans l'endomètre (nidation).

Cette nidation dure 7 jours.

III. DEVELOPPEMENT DE L'OEUF

Il y a deux grandes périodes au cours du développement de l'œuf : la période embryonnaire qui part de la fécondation jusqu'à la 7^{ème} semaine de grossesse, et la période fœtale qui part de la 8^{ème} semaine de grossesse jusqu'à la naissance.

III.1 Période embryonnaire :

- ❖ 1^{ère} semaine de grossesse : phénomène de fécondation, segmentation, migration et formation de blastocyste.
- ❖ 2^{ème} semaine de grossesse : correspond à la nidation pré gastrulation et l'ébauche des annexes internes (bouton embryonnaire)
- ❖ 3^{ème} semaine de grossesse : début du développement du système nerveux et de la circulation placentaire.
- ❖ 4^{ème} semaine de grossesse jusqu'à la 7^{ème} semaine de grossesse : période organogénétique marquée par la différenciation de la plupart des organes : épiderme, tissu nerveux, système digestif, rénal, circulatoire..., fermeture de la paroi abdominale et du tube neural.

III.2 Période fœtale :

Elle s'étend du deuxième mois de grossesse à la naissance.

L'œuf prend un visage d'être humain et va développer toutes les caractéristiques de base de ces organes : croissance accrue des organes et du corps, maturation des ébauches, réorganisation de ces rapports dans l'espace.

C'est une période de maturation et de croissance. Elle est marquée par :

- Une augmentation de la taille et de poids du fœtus,
- La transformation de l'apparence fœtale : réduction de la proportion de la tête fœtale, modelage de la face et croissance des membres,
- Un complément de différenciation des organes déjà mis en place, poursuite de l'organogenèse du système nerveux et de l'appareil génital.

Troisième mois de grossesse : fœtus	Les organes sexuelles se différencient dès le début du troisième mois et sont visibles extérieurement. le jeune fœtus pèse 45g et mesure 11cm. il commence à dépenser quelques forces en mouvements spasmodiques
Quatrième mois de grossesse : le fœtus prend un aspect vraiment humain.	L'aspect général commence à prendre des proportions plus normales : la tête semble moins volumineuse. Tout le corps se couvre d'un duvet et les premiers cheveux font leur apparition. Le foie et les reins entrent en activité. Les urines sont évacuées dans le liquide amniotique. ce quatrième mois : il pèse 225g et mesure 20cm
Cinquième mois de grossesse : première réaction auditive et tactile.	Les mouvements du fœtus sont maintenant bien perceptibles par la mère ou par contact avec son ventre. Les battements du cœur sont rapides (2 fois plus que l'adulte) et fort ; ils peuvent être perçus au stéthoscope. Par contre, il est capable d'avoir des réactions auditives et tactiles : il peut réagir à certains sons, à la parole, au contact avec les mains. Il pèse 700g et mesure 26 cm. La croissance va ralentir : le fœtus va profiter des 4 mois suivant pour perfectionner ses organes
Sixième mois de Grossesse : les Mouvements deviennent plus vigoureux.	La future mère peut ressentir de plus en plus fréquemment les mouvements du fœtus ; ce sont le plus souvent des coups de genoux et des coups de poings. Le sixième mois se termine avec un poids de 1kg et une taille de 31cm.
Septième mois de grossesse : le système nerveux se perfectionne.	Les organes de sens se développent ; les mouvements deviennent plus coordonnés : il est capable de se retourner complètement sur lui-même. Il pèse 1700g et mesure 40cm. Il est capable de survivre à une naissance prématurée.
Huitième et neuvième mois de grossesse	Le huitième mois l'amène à 2,5kg et 45cm. Au neuvième mois, ses mouvements seront très importants : il roule sur lui-même, détend bras et jambes.

NB : Un certain nombre d'organes n'achèvent leurs maturations qu'après la naissance c'est le cas du système reproducteur et des caractères sexuels associés, du cerveau et du cervelet.

CONCLUSION

La période de la fécondation à la naissance est marquée par plusieurs étapes importantes de transformation dont la connaissance est indispensable dans le suivi et la prise en charge de la grossesse.

MODIFICATIONS DE L'ORGANISME DE LA FEMME AU COURS DE LA GROSSESSE

INTRODUCTION

Au cours de la grossesse l'organisme maternel subit des modifications physiologiques indispensables au bon déroulement de la grossesse.

OBJECTIF GENERAL

Etre capable d'appréhender les modifications de l'organisme de la femme au cours de la grossesse.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1) Décrire les modifications de l'appareil reproducteur au cours de la grossesse.
- 2) Décrire les modifications générales survenant chez la femme enceinte.
- 3) Préciser la valeur normale des paramètres biologiques courants au cours de la grossesse.

I. MODIFICATIONS DE L'APPAREIL GENITAL ET DESSEINS

I.1 L'utérus

Il va devoir s'agrandir pour contenir un fœtus de 3000 à 4000 g à terme.

• Le corps utérin

Il reste pelvien au cours des deux premiers mois.

A partir du 3^{ème} mois, il devient abdominal et progressivement occupera toute la cavité abdominale. L'utérus gravide est globuleux et ramolli. Sa consistance peut être comparée à la papaye mûre.

• Le col utérin

Il est violacé, ramolli et il n'y a pas de glaire cervicale. Chez la primipare, il reste normalement long et fermé aux deux orifices jusqu'au début du travail. Chez la multipare, il peut être raccourci et déhiscent. Les glandes cervicales secrètent un mucus abondant et épais, appelé « bouchon muqueux ». Il protège les membranes (le bouchon muqueux s'évacue dans le vagin peu avant le début du travail).

• Le segment inférieur

C'est la zone de transition entre le corps et le col utérin. Il se constitue au 3^{ème} trimestre de la grossesse.

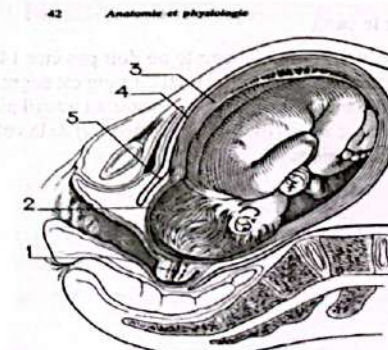


FIG. 57. — Utérus gravide avec ses trois parties.
1: col ; 2: segment inférieur ; 3: corps ; 4: périnée antérieur ; 5: périnée postérieur.

Schéma 11 : Utérus gravide avec ses trois parties

I.2 Le vagin et le périnée

• Le vagin

Il prend un aspect violacé. Il s'allonge et s'élargit. Ses parois deviennent plus souples.

• Le périnée

Il est assoupli grâce aux imbibitions gravidiques. La distance ano-vulvaire, long de 2 à 3 cm et atteindra 12 cm environ au moment de l'expulsion du fœtus.

I.2 Les seins

Ils augmentent de volume et deviennent tendus, parfois douloureux. Les aréoles deviennent bombantes et plus foncées, avec une saillie des tubercules de MONTGOMERY. La circulation veineuse sous cutanée est visible, formant le réseau de HALLER.

II. MODIFICATIONS GÉNÉRALES

II.1 L'appareil digestif

De nombreuses perturbations surviennent dans son fonctionnement au cours de la grossesse.

- Nausées et vomissements matinaux se manifestent au cours des 2 premiers mois. On note quelques fois des difficultés de digestion appelées flatulence. A cela, il faut ajouter les pyrosis qui sont une sensation de brûlure en arrière de la gorge après le repas.
- L'intestin grêle et le gros intestin sont déplacés par le développement de l'utérus. Le rectum et l'os iliaque sont comprimés par la présentation, d'où la gêne de la circulation intestinale qui a pour conséquences constipations et hémorroïdes.

II.2 L'appareil urinaire

La dysurie et la pollakiurie sont fréquentes. On les attribue à la compression de la vessie par l'utérus gravide. La grossesse entraîne assez souvent une légère glycosurie qui s'explique par un abaissement du seuil rénal du glucose.

II.3 L'appareil respiratoire

La distension de l'utérus entraîne un gêne respiratoire en fin de grossesse. Les besoins en O_2 sont accrus chez la femme enceinte (ceci est en rapport avec l'augmentation des différents métabolismes et avec la nécessité de satisfaire aux besoins du fœtus dépourvu de moyen d'oxygénation). Il y a une congestion de toute la muqueuse de l'arbre respiratoire.

II.4 L'appareil circulatoire et le sang

Normalement, la TA diminue. La TA d'une femme enceinte ne doit pas être 140/90 mmHg. Au-delà de ces chiffres, il s'agit d'une hypertension artérielle. Le volume total du sang est augmenté, mais la numération et la formule sanguine reste normale sauf pendant les derniers mois jusqu'au travail où existe une hyperleucocytose normale. Les varices sont fréquentes au niveau des membres inférieurs et de la vulve. Elles sont dues davantage à une diminution du tonus des parois des veines.

II.5 Le système nerveux

Les modifications surviennent au début et se manifestent par :

- Une irritabilité
- La tristesse
- Des envies
- des dégoûts
- un changement de caractère

Au cours des 2 derniers mois, elles se manifestent par des insomnies.

II.6 La peau

Elle subit une pigmentation caractérisée par :

- L'apparition de la ligne brune abdominale
- L'aréole des seins qui devient plus foncée
- L'apparition du classique « masque des grossesses »

Il y a apparition de vergetures sur l'abdomen chez certaines femmes (ce sont des cicatrices indélébiles), à la face postérieure des mollets, sur les cuisses et les seins. La pigmentation de la peau est due à la concentration élevée d'hormone mélanotropes qui pourrait elle-même résulter de l'augmentation d'œstrogènes et de la progestérone.

II.7 Le poids

Il chute au début de la grossesse, puis il y a une augmentation de 20-24%, répartie sur les trois trimestres. L'augmentation du poids au cours de la grossesse est d'environ 12 kg. La prise de poids moyenne est de 1-1,5 Kg/mois. Cette prise de poids est rapide à partir du 5^{ème} mois.

II.8 Le métabolisme

Au cours des 2-3 premiers mois de la grossesse, la température est plus élevée qu'à l'état pré-gravidique. Cela est dû à la persistance de l'activité lutéinique de la 2^{ème} phase du cycle menstruel. Puis, cette température diminue. Elle est même inférieure à 37°C au 2^{ème} et 3^{ème} trimestre.

LES CONSTANTES BIOLOGIQUES

Quelques constantes biologiques au cours de la grossesse

Dans le sang	Avant la grossesse	Au cours de la grossesse
- Volume plasmatique (en ml)	2600	3600
- Hématocrite (%)	37-47	> 35
- Hémoglobine (g/100 ml)	12-17	> 11
- Valeur moyenne globulaire (p ³)	85-95	171
- Leucocytes (mm ³)	6000-8000	10000-15000
- Plaquette (mm ³)	150000-300000	Idem
- Acide urique (uricémie) mg/l	30-70	<40 avant 32s <60 après 32s
- Urée (g/l)	0,15-0,45	0,20 << 0,40
- Créatinine (mg/l)	6-14	4-8
- Glycémie à jeun (g/l)	0,75-1,10	0,6-1 g
- Fer sérique (mg/l)	0,6-1,6	>0,42
Dans les urines		
- Albumine (g/l)	0	0
- Sucre (g/l)	0	0

CONCLUSION

La grossesse impose un hyperfonctionnement à l'organisme de la femme. Celui-ci subit alors dans son ensemble des modifications plus ou moins supportées par la femme. Il appartient donc à la sage-femme de bien les expliquer afin d'amener la gestante à mieux les vivre car, elles ne sont pas pathologiques.

DIAGNOSTIC POSITIF DE LA GROSSESSE AU DEBUT

INTRODUCTION

Le diagnostic de la grossesse au début est nécessaire afin de déterminer son siège et les facteurs de risque.

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les éléments du diagnostic de la grossesse au début.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1) Enumérer les principaux signes sympathiques de la grossesse au début.
- 2) Déterminer les éléments du toucher vaginal au début de la grossesse.
- 3) Identifier les deux examens para cliniques permettant de poser le diagnostic de la grossesse au début

I. DIAGNOSTIC CLINIQUE DE LA GROSSESSE

Il repose sur l'interrogatoire et l'examen physique.

I.1 Les signes cliniques

I.1.1 Interrogatoire

Recherche :

- Une aménorrhée secondaire (femme jusque là bien réglée) +++
- Des signes sympathiques de la grossesse (sont variable et nombreux):
 - o Troubles digestifs : Nausées, Vomissements, Hyper salivorrhée, modification de l'appétit, modification du goût, constipation.
 - o Trouble nerveux : Emotivité et irritabilité, Trouble du sommeil (somnolence), fatigabilité.
 - o Trouble urinaire : Pollakiurie
 - o Modification du métabolisme : Plateau thermique supérieur à 37°C prolongé plus de 16 jours, gonflement général*

I.1.2 Examen physique (vessie et rectum vide de préférence)

- A l'inspection:
 - o Augmentation du volume seins, tension des seins, hypersensible
 - o Hyper pigmentation de l'aréole
 - o Saillie des tubercules de Montgomery
 - o Hyperpigmentation des organes génitaux externes (parfois)
- A la palpation:

La palpation du pelvis peut ne pas retrouver une augmentation de la taille de l'utérus lorsque l'âge de la grossesse est inférieur à 8 semaines

- Au spéculum :
 - o Le col est violacé;
 - o La glaire cervicale est coagulée ou absente.
- Au toucher vaginal (combiné au palper abdominal) :
 - o Le col est long, de consistance ramollie (mou comme les lèvres, signe de Tarnier), position généralement postérieure ;
 - o L'utérus augmente de volume (le fond utérin est perçu au-dessus de la symphyse pubienne), arrondi, globuleux, de consistance ramollie surtout au niveau de l'isthme permettant aux doigts vaginaux et abdominaux d'être facilement en contact à tel point que le corps de l'utérus semble être détaché du col, c'est le signe de Hegar;

- o Les culs de sacs latéraux sont comblés par l'augmentation du volume utérin, c'est le signe de Hegar.
- Le diagnostic précoce de la grossesse peut être moins évident, lorsque la femme a un cycle menstruel irrégulier (la date des dernières règles imprécise, des saignements anormaux). Dans ce cas la biologie aide au diagnostic.



Schéma 12: Toucher vaginal combiné au palper

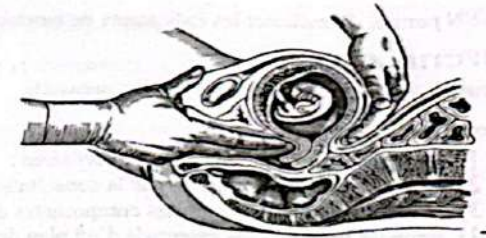


Schéma 13 : Signe de HEGAR

II. DIAGNOSTIC PARA CLINIQUE

II.1 Diagnostic biologique de la grossesse

Ce diagnostic est confirmé par la recherche qualitative des bêta HCG dans les urines et dans le sang. Le dosage peut être quantitatif dans le sang, c'est-à-dire le résultat est exprimé en chiffre.

II.2 diagnostic échographique (imagerie)

Echographie pelvienne

Il ya deux types : abdominale et vaginale

Elle permet de faire le diagnostic de la grossesse de préciser :

- le siège (intra utérine ou extra utérine),
- l'âge de la grossesse
- précocement la vitalité
- le nombre d'embryons.
- l'existence de pathologies associées (kyste ovarien, fibrome utérin,...)

CONCLUSION

Le diagnostic de la grossesse au début est basé sur des signes cliniques dominés par l'aménorrhée et les modifications de l'utérus et par les examens para cliniques (dosage du bêta HCG et échographie).

NOTION SUR LES CONSULTATIONS PRENATALES

INTRODUCTION

La CPN permet d'améliorer les indicateurs de mortalité maternelle et infantile

OBJECTIF GENERAL

Connaître les éléments de la consultation prénatale.

Objectifs spécifiques

- 1) Définir la consultation prénatale recentrée ;
- 2) Énumérer les cinq principes de la consultation prénatale recentrée ;
- 3) Décrire les quatre principales composantes des soins prénatals recentrés ;
- 4) Énoncer les éléments essentiels d'un plan de préparation à l'accouchement et aux complications.

I. DEFINITION

La CPN recentrée est basée principalement sur 4 approches des soins prénatals qui insiste sur :

1. Des actions basées sur l'évidence et orientée vers un objectif
2. Des soins individualisés axés sur chaque femme
3. La qualité des visites par opposition à leur nombre en faisant une analyse pertinente des résultats de la séance de CPN
4. Des soins donnés par des prestataires compétents ; il s'agit d'actions ciblées et non routinières.

II. PRINCIPES

Dans le concept de la CPN recentrée, on distingue cinq (5) principes.

II.1 Évaluation

Évaluation focalisée à chaque visite prénatale (dépister et traiter les maladies préexistantes et les complications).

II.2 Soins individualisés

Prenant en compte :

- la prévention des complications et des maladies
- La préparation à l'accouchement et aux complications
- la promotion de la santé

II.3 Counseling et soutien

Ils permettent à la femme de :

- Prendre une part active aux soins ;
- Prendre des décisions adéquates ;
- Mener une vie saine pour préserver sa santé ;
- Suivre les conseils prodigués ;
- Faire confiance au prestataire.

II.4 Soins centrés sur la femme

Ils mettent l'accent sur :

- La priorité donnée à la santé / suivie de la mère et du nouveau-né ;
- Le respect des droits, de la culture, des croyances et du genre ;
- Les messages et conseils de santé appropriés, faisables en fonction du contexte ;
- L'accessibilité des services par les femmes ;
- L'utilisation d'une bonne communication interpersonnelle.

II.5 Soins assurés par un prestataire qualifié et compétent

- Médecin
- Sage-femme (SF)
- Infirmier (IDE).

III. COMPOSANTES DE LA CPN

Quatre composantes constituent la CPN

1. Dépistage et prise en charge (PEC) des maladies préexistantes et des complications
2. Prévention des complications et des maladies
3. Préparation à l'accouchement et aux complications éventuelles
4. Promotion de la santé

III.1 Dépistage et PEC des maladies préexistantes et des complications

- Paludisme (fièvre, anémie, goutte épaisse / Frottis ou test de diagnostic rapide)
- Infections urinaires (dysurie, pollakiurie, fièvre, douleurs pelviennes, lombaires, ECBU)
- Pré éclampsie (HTA, œdèmes des membres inférieurs, réflexes tendineux, protéinurie)
- Anémie (pâleur des conjonctives, des paumes, de la langue ; taux d'hémoglobine et d'hématocrite)
- Maladie des seins (douleurs mammaires, nodules mammaires, écoulement mammaire anormal)
- Retard de croissance, mort fœtale (MAF, HU, BDCF)
- Infections sexuellement transmissibles (leucorrhées, condylomes vulvaires, examen pelvien et au spéculum)
- Cancer du col (Inspection visuelle, examen pelvien et au spéculum)

Nombre de CPN minimum (04) pour les grossesses normales selon les directives paquet minimum d'activité (PMA) de la Côte d'Ivoire.

• La 1^{ère} CPN : avant la fin du 3^{ème} mois

- Diagnostiquer la grossesse
- Calculer le terme
- Etablir la déclaration de grossesse
- Dépister les facteurs de risque
- Prescrire le bilan prénatal.
- Etablir le Calendrier de suivi de la grossesse
- Conseils et prévention paludisme (MILDA), supplémentation en acide folique, vaccinations (VAT et hépatite B)

IV. DEROULEMENT DE LA CPN

• La 2^{ème} CPN : 4^{ème} au 6^{ème} mois

- Suivre l'évolution de la grossesse
- Rechercher les facteurs de risque de prématurité
- Traiter les maladies courantes et associées
- Faire la prophylaxie antianémique
- Donner la 1^{ère} dose de la chimio prophylaxie anti palustre(TPI)
- Vacciner si nécessaire.

- La 3^{ème} CPN : entre le 7^{ème} et le 8^{ème} mois
 - Apprécier l'évolution de la grossesse (recherche des signes de prématurité)
 - Sensibiliser à l'environnement de l'accouchement
 - Vacciner si nécessaire
 - Donner la 2^{ème} et la 3^{ème} dose des TPI
- La 4^{ème} CPN : 9^{ème} mois (deux semaines avant le terme probable de l'accouchement)
 - Faire le pronostic de l'accouchement
 - Référer en cas de besoin
 - Faire la vaccination si nécessaire

V. CONTENU DES COMPOSANTES DE LA CPN RECENTRE

V.1 Bilan au cours de la grossesse

V.1.1 Examens obligatoires selon le PMA

- Groupe sanguin (ABO + Rhésus)
- Sérologie de la toxoplasmose (si négatif surveiller tous les mois)
- Sérologie de la rubéole (au 1^{er} Trimestre)
- Sérologie de la syphilis (VDRL RPHA)
- Glycémie

V.1.2 Autres examens conseillés

- NFS (Taux d'hémoglobine et hématocrite)
- Electrophorèse de l'hémoglobine
- Albumine et sucre dans les urines (à toutes les CPN)
- Nitrite dans les urines (si positif faire un ECBU)
- Sérologie VIH après consentement éclairé
- Sérologie de l'hépatite B (Antigène HBs)
- Examen d'échographie (03)
 - o 1^{ère} diagnostic de grossesse au 1^{er} Trimestre
 - o 2^{ème} morphologie fœtale au 2^{ème} Trimestre
 - o 3^{ème} pronostic de l'accouchement au 3^{ème} Trimestre

V.2 Prévention des complications et des maladies

Chaque femme enceinte doit bénéficier des mesures préventives suivantes :

- Vaccination antitétanique
- Supplémentation en fer/folate
- Prévention du paludisme
- Prévention des troubles dus à la carence en iode par consommation de sel iodé.

V.3 Préparation à l'accouchement et aux complications éventuelles

- Identification d'un prestataire qualifié pour l'accouchement
- Identification du lieu de l'accouchement
- Identification du moyen de transport pour se rendre à l'hôpital
- Identification des moyens financiers
- Identification du système de prise de décisions en cas d'urgence
- Identification de donneurs de sang
- Identification du soutien familial pendant le séjour à la maternité
- Identification des articles nécessaires le jour de l'accouchement.

V.4 Promotion de la santé

Elle peut se faire au centre de santé ou dans la communauté à travers plusieurs thèmes de CCC en rapport avec la situation actuelle de la femme (prévention du paludisme, l'alimentation de la femme enceinte et du nouveau-né, l'hygiène générale, la planification familiale etc.)

CONCLUSION

La CPN permet la PEC individualisée de la femme enceinte, luttant ainsi contre la mortalité maternelle et néonatale.

INTRODUCTION

Le diagnostic de la présentation fœtale est indispensable pour le choix du mode d'accouchement.

OBJECTIF GENERAL

Connaître les différentes présentations du fœtus pendant la grossesse et lors de l'accouchement.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1) Définir la présentation ;
- 2) Citer les différents types de présentations fœtales ;
- 3) Préciser le repère dans chaque type de présentation.

I. GENERALITES

I.1 Définitions

- **Présentation** : C'est la partie du fœtus qui se présente en premier au contact de l'aire du détroit supérieur du bassin obstétrical.
- **Repère** : C'est la partie de la présentation qui se place en regard de l'extrémité antérieure ou postérieure d'un diamètre oblique du détroit supérieur du bassin obstétrical.

I.2. Différents types de présentation

On distingue 3 grandes variétés :

- **Les présentations céphaliques (4)** qui sont :
 - Présentation du sommet (tête bien fléchie)
 - Présentation du bregma (déflexion légère)
 - Présentation du front (déflexion accentuée)
 - Présentation de la face (déflexion maximale)
- **Les présentations du siège (2)**
 - Présentation du siège complet (mode des pieds)
 - Présentation du siège décomplet (mode des fesses)
- **Les présentations transversales (3)**
 - Présentation transversale
 - Présentation de l'épaule
 - Présentation de l'épaule négligée

II. DIFFERENTES PRESENTATIONS CEPHALIQUES

II.1 Présentation du sommet

- C'est une présentation céphalique, longitudinale où la tête est bien fléchie.
- Le menton s'appuyant sur la face antérieure du thorax.
- **Repère** : C'est l'occiput ou lambda ou la petite fontanelle.
- **Diamètre d'engagement** = sous-occipito-bregmatique = 9,5cm

NB : L'accouchement en présentation du sommet est eutocique et se fait par voie basse en l'absence d'autres complications.

II.2 Présentation du bregma

- C'est une présentation céphalique, longitudinale avec une tête ni fléchie ni défléchie, elle est intermédiaire entre le front et le sommet.
- C'est une variété de la présentation du front
- C'est une présentation du travail
- **Repère** : C'est le bregma ou fontanelle losangique ou grande fontanelle
- **Diamètre d'engagement** = occipito-frontal = 12cm

NB : césarienne = décision sage

II.3 Présentation du front

- C'est une présentation céphalique, longitudinale avec la déflexion partielle (moyenne) de la tête fœtale.
- C'est une présentation Hautement dystocique
- **Repère** : C'est la pyramide nasale ou la racine du nez.
- **Diamètre** : Syncipito-mentonnier = 13,5 cm

NB : Césarienne obligatoire

II.4 Présentation de La face :

- C'est une présentation céphalique, longitudinale avec la déflexion totale de la tête fœtale accompagnée d'une lordose importante.
- **Repère** : C'est le menton
- **Diamètre** : sous-menton-bregmatique = 9,5 cm et le presterno- syncipital = 13,5cm

NB : Césarienne obligatoire si variété postérieure

REMARQUE : La césarienne est conseillée en cas de présentation de la face à cause des complications suivantes :

- Arrêt de la progression de la présentation
- Défaut d'engagement
- Lenteur du travail
- Procidence du cordon
- Rotation du menton en arrière
- Présentation haute
- Souffrance fœtale

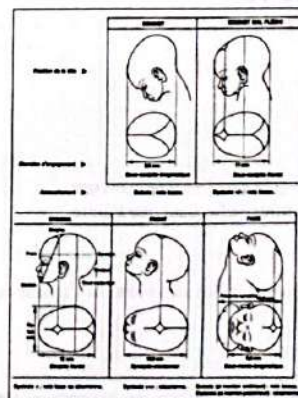


Schéma 14 : Type de présentation céphalique

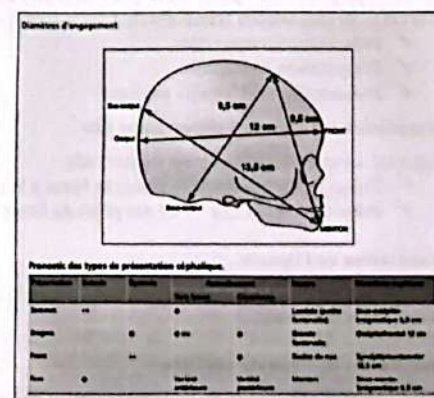


Schéma 15 : Diamètre d'engagement en fonction de la flexion de la tête

III. PRESENTATIONS DE SIEGE

- C'est une présentation longitudinale où le fœtus présente au détroit > son pôle (extrémité) pelvien.
- Repère: sacrum
- Diamètres
 - o Siège : bi trochantérien = 9,5cm
 - o Epaule : bi-acromial = 11 cm
 - o Tête : sous-occipito-frontal = 12 cm

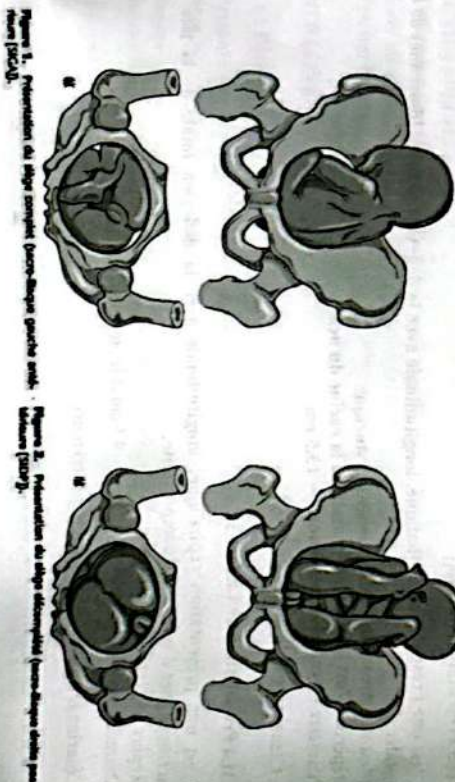


Schéma 16 : Présentations de siège

IV. Présentation transversale ou de l'épaule :

- C'est lorsqu'en fin de grossesse ou pendant le travail, l'aire du détroit supérieur n'est occupée ni par la tête fœtale ni par son siège.
- Repère : moignon de l'épaule ou le grill costal ou l'acromion
- différentes présentations transversales :
 - ✓ Présentation transversale
 - ✓ Présentation de l'épaule
 - ✓ Présentation de L'épaule négligée
- Présentation transversale proprement dite

On distingue 02 variétés de présentation transversale :

- ✓ Présentation transversale vraie : le fœtus a la tête et le siège au même niveau
- ✓ Présentation oblique : l'un des pôles du fœtus se trouve plus haut que l'autre.

- Présentation de l'épaule

C'est une présentation où le fœtus est en position oblique et présente un des moignons de l'épaule au détroit supérieur du bassin maternel.

- Présentation de l'épaule négligée

C'est l'aboutissement obligatoire de toute présentation de l'épaule dès la rupture des membranes sur un utérus plus ou moins rétracté avec un fœtus mort pendant le travail. Cliniquement on aura :

- La procidence d'un bras
- L'on sent dans le vagin lors du TV : Le coude, Le bras, La main

CAT dépend de :

- Si fœtus mort macéré : Laisser évoluer
- Si fœtus vivant ou mort non macéré : la césarienne ne doit pas être retardée à cause des complications pour la mère et pour le fœtus.

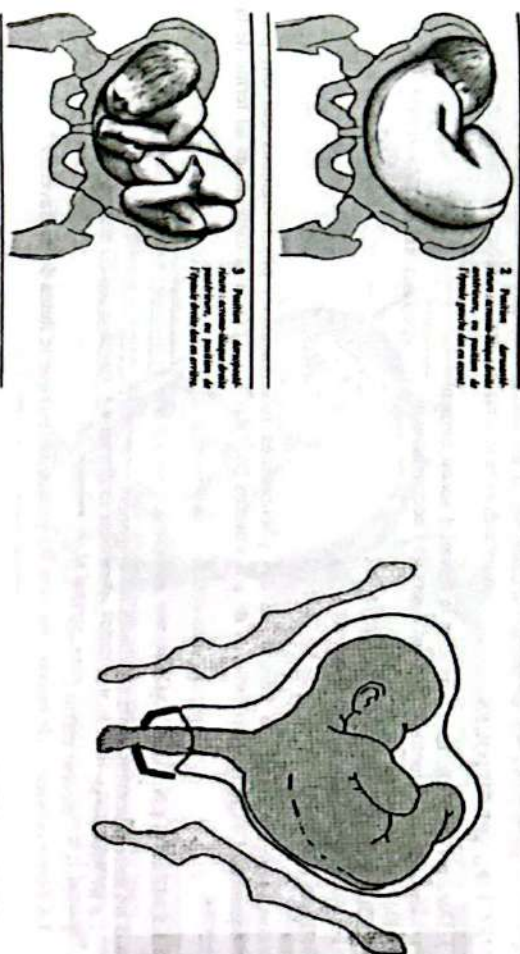


Schéma 17 : Présentation transversale

Schéma 18 : Présentation Épaule négligée

CONCLUSION

Il existe plusieurs variétés de présentation faciale dont il est important d'en faire le diagnostic afin d'adapter la conduite à tenir.

MECANISME GENERAL DE L'ACCOUCHEMENT

INTRODUCTION

Les notions sur le mécanisme de l'accouchement permettent de mieux comprendre les différentes étapes de l'accouchement.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Comprendre le mécanisme de l'accouchement normal.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- 1) Définir l'accouchement normal et le travail d'accouchement
- 2) Identifier les éléments en présence lors de l'accouchement
- 3) Définir l'engagement
- 4) Citer les différentes étapes du travail

1. DÉFINITIONS

L'accouchement normal est l'ensemble des phénomènes mécaniques et physiologiques qui ont pour conséquence l'expulsion du fœtus et de ses annexes hors des voies génitales maternelles au terme de la grossesse.

1.1. ÉLÉMENTS EN PRÉSENCE

Lors d'un accouchement, trois éléments interviennent :

- Le fœtus fœtal
- L'utérus ou noyau utérin qui loge le fœtus
- La filière pévienne (le bassin osseux et les parties molles) que le fœtus devra traverser

1.1.1 Le fœtus fœtal

En fin de grossesse, le fœtus prend sa position définitive qui est généralement longitudinale en présentation céphalo-pied fléchie. L'élément principal étant les dimensions de la tête fœtale.



Schéma 19 : Vue générale à terme



Schéma 20 : Dimension de la tête fœtale

1.1.2 L'utérus ou noyau utérin

Quant à la grossesse, le muscle utérin a la forme d'un gobelet renversé et se contracte en expulsant le liquide amniotique et relie au placenta par le cordon ombilical.

L'utérus comprend trois parties qui sont :

- Le corps utérin : constitué de nombreux fibres musculaires lisses possédant trois propriétés qui sont : l'élasticité, la tonicité, la contractilité.
- Le segment inférieur : partie intermédiaire entre le corps et le col de l'utérus qui s'amincit et prend la forme de la présentation en fin de grossesse.
- Le col de l'utérus : reste normalement fermé jusqu'à l'entrée en travail où il est soumis à des contractions qui entraînent son effacement et sa dilatation.



Schéma 21 : Expulsion à dilatation complète

1.1.3 La filière pévienne (voir aussi bassin ostéopelvien)

Canal étroit constitué par le bassin osseux fixe, inextensible et des parties molles extensibles formées de plusieurs plans musculaires superposés.

II. LES DIFFÉRENTES PHASES DE L'ACCOUCHEMENT

L'accouchement se déroule en trois grandes phases :

- La phase du travail
- La phase de l'expulsion
- La phase de délivrance

II.1 La phase du travail

Le travail est la première phase de l'accouchement. Il est marqué par les contractions utérines et se subdivise en plusieurs étapes.

II.1.1 Les contractions utérines

En fin de grossesse il y a blocage de la progestérone et libération des oxytocines qui entraînent l'apparition des contractions utérines. Ces contractions utérines ont les caractéristiques suivantes :

- Progressives dans leur durée et leur intensité ;
- Totales ;
- Douloureuses. La sensation douloureuse ne commence qu'après le début de la contraction et se termine avant la fin. Elle augmente avec l'angoisse. Elle diminue avec une bonne préparation psychique et est supprimée par l'anesthésie péridurale.

Les contractions utérines du travail sont caractérisées par :

- Leur intensité (50 à 60 mmHg) ;
- Le tonus de base entre les contractions (10 mmHg) ;
- La durée (20 secondes au début, 60 secondes à la fin) ;
- Leur rythme (3 à 4 contractions toutes les 10 minutes) ; l'intervalle entre les contractions diminue progressivement, mais permet la circulation placentaire.

Les contractions utérines qui constituent le moteur ont trois effets :

- Augmentation de la pression intra-utérine,
- Appui sur le col par l'intermédiaire de la poche des eaux ou/et de la présentation fœtale,
- Effet de traction directe sur le col par l'intermédiaire du segment inférieur et du raccourcissement des fibres utérines (permettant l'effacement et la dilatation du col).

III.1.2 Les étapes du travail :

- L'effacement du col
- La dilation du col
- La formation de la poche des eaux
- La progression du fœtus

III.1.2.1 L'effacement du col

Sous l'influence des contractions utérines, le col utérin va se raccourcir progressivement et s'effacer ainsi, l'orifice interne et externe du col finissent par se confondre.

III.1.2.2 La dilatation du col

La dilation du col fait suite à son effacement sous l'effet des contractions utérines. L'orifice du col qui après l'effacement est d'un centimètre de diamètre, s'agrandit progressivement pour atteindre une dilatation d'environ 10 cm, dite dilatation complète. La dilatation est plus lente au début (1 cm par heure) qu'à la fin du travail. Elle s'accompagne d'un phénomène très important qui est la formation de la poche des eaux.

III.1.2.3 La formation de la poche des eaux

Lorsque la dilatation commence, on découvre une membrane qui va bomber dans l'orifice cervical. Cette membrane est très mince et transparente à travers elle on voit le liquide amniotique ; c'est la poche des eaux. Elle joue un rôle de protection (protège le fœtus contre les infections, contre le traumatisme des contractions utérines et isole le fœtus de la cavité vaginale) et de dilatation (favorise la dilatation cervicale).

Sous l'effet des contractions utérines la poche des eaux finit par se rompre : c'est la rupture spontanée des membranes.

Lorsque cette rupture survient avant l'entrée en travail on parle de rupture prématurée des membranes.

Si elle survient avant la dilatation complète du col, il s'agit d'une rupture précoce des membranes.

A dilatation complète, c'est la rupture tempestive.

Elle est dite artificielle lorsqu'elle est faite par l'accoucheur.

III.1.2.4 Progression du fœtus dans la filière pelvienne

La progression du fœtus se fait en deux temps :

- L'engagement
- La descente et la rotation

III.1.2.4.1 L'engagement de la présentation (sommets)

C'est le franchissement du plan du détroit supérieur du bassin maternel par le plus grand diamètre de la présentation fœtale.

La tête fœtale s'engage dans l'un des diamètres oblique du bassin (gauche ou droite). Elle s'oriente pour faire coïncider son axe et son meilleur diamètre (sous occipito bregmatique 9,5 cm) avec celui du détroit supérieur. Elle s'amoindrit pour mieux s'adapter à l'aire d'engagement par modelage (chevauchement des os du crâne, tassement) et modification d'attitude (la flexion de la tête).

Ce phénomène est essentiel car il diminue de manière significative les diamètres de la présentation à l'aire du détroit supérieur.

Ainsi au cours du travail, nous pouvons trouver l'occiput à l'extrémité antérieure ou postérieure du diamètre oblique gauche ou droit du bassin osseux. On individualise donc la variété de position ou présentation selon la situation de l'occiput :

- **Occipito iliaque gauche antérieure (OIGA).** La plus fréquente des cas 66%, c'est quand l'occiput est situé à l'extrémité antérieure du diamètre oblique et du côté de l'os iliaque gauche de la mère.
- **Occipito iliaque droit postérieur (OIDP).** Quand l'occiput est situé à l'extrémité postérieure du diamètre oblique et du côté de l'os iliaque droit de la mère.
- **Occipito iliaque droit antérieur (OIDA).** Quand l'occiput est situé à l'extrémité antérieure du diamètre oblique et du côté de l'os iliaque droit de la mère.
- **Occipito iliaque gauche postérieur (OIGP).** Quand l'occiput est situé à l'extrémité postérieure du diamètre oblique et du côté de l'os iliaque gauche de la mère.
- Occipito iliaque gauche postérieure (OIGP) et droite antérieure (OIDA), sont les variétés beaucoup plus rares.



Planche 122. Accouchement en occipito-iliaque gauche antérieure (OIGA).

Schéma 22: Accouchement en occipito-iliaque gauche antérieure

- Diagnostic de l'engagement

Une présentation est dite engagée lorsqu'au toucher vaginal, on ne peut faire passer les deux doigts vaginaux entre la présentation et la concavité sacrée : c'est le signe de « FARABEUF », le plus utilisé pour faire le diagnostic de l'engagement.

III.1.2.4.2 La descente et la rotation

Ces deux mouvements peuvent être simultanés ou successifs. La tête descend progressivement dans l'excavation pelvienne et sous l'effet des contractions utérines la tête faciale descend dans l'excavation par le mécanisme d'asynclitisme : on dit que la tête plonge dans l'excavation dans un mouvement d'un battant de cloche.

A ce niveau se produit une rotation intra-pelvienne obligatoire. La rotation se fait presque toujours en avant en ramenant l'occiput sous la symphyse pubienne (O.P.). Les variétés antérieures OIGA, OIDA font une petite rotation très facile et rapide de 45° et les variétés postérieures OIGP, OIDP doivent faire une grande rotation laborieuse de 135° pour pouvoir caler l'occiput sous la symphyse pubienne. Quelque rare fois les variétés postérieures font une rotation en arrière de 45° en emmenant l'occiput au niveau du sacrum (c'est la position occipito sacrée d'où dégagement en OS).

III.1.2.4.3 la phase d'expulsion ou de dégagement

Au terme de la descente, se produit le dégagement qui est le franchissement du détroit inférieur et du diaphragme périnéal par la présentation. Le dégagement se fait presque toujours en O.P. La présentation arrive au niveau du détroit inférieur et vient buter contre le plancher périnéal. La région sous occipitale se fixe au bord inférieur de la symphyse pubienne sous laquelle elle va pivoter tandis que le front amplie le périmètre postérieur qui est laminé et la distance ano-vulvaire augmente jusqu'à 10 cm.

A ce moment les contractions utérines deviennent plus intenses et plus rapprochées et déclenche le besoin de pousser chez la parturiente.

L'accoucheur se place du côté droit de la femme et lui demande de pousser dès qu'elle ressent des contractions utérines.

A chaque effort expulsif, la présentation disend progressivement le plancher périnéal. La fourchette vulvaire est repoussée en avant, l'orifice vulvaire tout en s'élargissant tend à devenir horizontal. La présentation effectue un mouvement de déflexion et laisse apparaître successivement les bosses parétales, le front, les yeux le nez, la bouche et le menton.

Ce passage doit être progressif et contrôlé par l'accoucheur pour éviter les déchirures du périnée (si ce dernier est très tendu une épisiotomie est nécessaire). Le dégagement de la tête se fait soit en occipito pubien (OP) soit en occipito sacrée (OS) selon la rotation faite par la présentation.

Après le dégagement de la tête se produit une seconde rotation : l'occiput se tourne de 45° vers le dos du fœtus. L'accoucheur saisit la tête entre le sous occiput et le menton fait une traction douce mais ferme vers le bas pour dégager l'épaule antérieure ensuite fait une traction vers le haut pour dégager l'épaule postérieure tout en surveillant le périnée.

Après le dégagement des deux épaules l'accoucheur tire le fœtus horizontalement pour dégager le reste du corps qui se fait sans difficulté.

Le cordon ombilical est clampé et sectionné à distance de l'abdomen.

NB: avant le dégagement réunit le matériel d'accouchement, mettre la femme en position gynécologique, faire sa toilette et lui expliquer à quel moment et comment pousser.

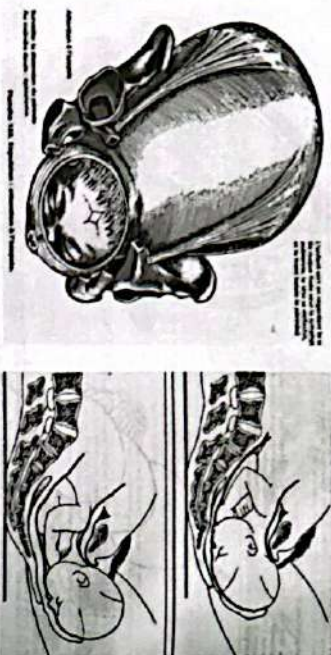


Schéma 23 : Expulsion de la tête faciale « H. de TOLURIS, gynécologie et obstétrique »

III.1.2.4.4 la phase de la délivrance
3^{ème} phase de l'accouchement consiste en l'expulsion du placenta et de ses membranes hors des voies génitales après l'expulsion du fœtus.



Schéma 24 : Délivrance normale

CONCLUSION

Les notions sur le mécanisme général de l'accouchement normal, permettent de comprendre le déroulement de ce dernier et ainsi de dépister les anomalies pouvant survenir pendant l'accouchement qui met en présence 3 éléments : le bassin ; le fœtus ; et le moteur qui est la contraction utérine.

INTRODUCTION

Dernière étape de l'accouchement mais période de nombreuses complications, son mécanisme doit être connu pour dépister de façon précoce les anomalies.

OBJECTIF GENERAL

Être capable d'acquérir des connaissances sur la délivrance normale.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1) Définir la délivrance normale
- 2) Décrire les différentes phases de la physiologie de la délivrance normale
- 3) Décrire avec exactitude la technique de la délivrance normale

I. GENERALITES

I.1 Définition

La délivrance est l'expulsion hors des voies génitales maternelles des annexes fœtales (placenta et membranes), initialement accolées à la paroi utérine, environ une demi-heure après la sortie du fœtus. C'est la troisième phase de l'accouchement.

On distingue deux types de délivrance normale :

- **Délivrance normale spontanée** : se fait sans aucune intervention. Le placenta et ses membranes sont expulsés entièrement sous l'effet des contractions utérines et des efforts expulsifs maternels.
- **Délivrance normale naturelle** : intervention de l'accoucheur au moment de l'expulsion du placenta.

I.2. Intérêt

La délivrance est la période la plus dangereuse pour la mère du fait de la survenue d'hémorragie pouvant mettre en jeu le pronostic vital de cette dernière. Ce risque d'hémorragie peut être évité en respectant toutes les étapes d'une délivrance normale.

II. LA PHYSIOLOGIE DE LA DELIVRANCE NORMALE

Elle évolue en cinq phases.

II.1. Phase de rémission ou phase de repos physiologique

Elle suit immédiatement la sortie du fœtus et dure 10 à 15 minutes environ. Elle est marquée par l'arrêt des contractions utérines et la rétraction de l'utérus sur le placenta. La femme est calme et ne ressent pas de contractions utérines.

✓ Sur le plan clinique

- L'utérus est rétracté en dessous de l'ombilic
- Il est visible au travers de la paroi abdominale
- Au niveau de la vulve s'écoule le liquide amniotique très peu sanglant.

✓ La surveillance portera sur :

- L'écoulement vulvaire
- La taille utérine
- Le pouls et la T.A

NB : Au cours de cette phase il faut éviter toutes manœuvres intempestives (expression utérine, massage utérin, traction sur le cordon) risquent de provoquer des complications.

II.2 La phase de décollement

Les contractions utérines reprennent au bout de 15 à 20 minutes, s'accroissent progressivement et sont éventuellement de nouveau ressenties par l'accouchée. Un clivage franc apparaît dans l'épaisseur de la caduque suivie de la constitution d'un hématome retro placentaire physiologique qui aide à parfaire le décollement.

✓ Sur le plan clinique

- Les contractions utérines sont perçues par l'accouchée
- Un filet de sang s'écoule à la vulve
- Le fond utérin remonte de 3 à 4 cm au-dessus de l'ombilic, souvent incliné vers la droite
- Le cordon ombilical se déroule hors de la vulve

II.3 Phases de migration

Sous l'influence des contractions utérines, de son propre poids, de l'hématome retro placentaire, le placenta migre vers le segment inférieur qu'il déplisse surélevant ainsi le fond utérin, la migration se poursuit vers le vagin puis l'orifice vulvaire.

II.4 Phase d'expulsion

L'expulsion peut se faire spontanément sous l'action des contractions utérines et des poussées maternelles. Le plus souvent elle est aidée par l'accoucheur qui doit s'assurer que le placenta est bien décollé (Pour confirmer le décollement ; la pression utérine sus pubien en déplissant le segment inférieur ne fait pas remonter le cordon).

II.5 Phase d'hémostase

La rétraction de l'utérus par contraction de ses fibres musculaire va étreindre et obturer les vaisseaux sanguins qui traversent la paroi utérine. C'est la **ligature vasculaire vivante de Pinard**, qui constitue le mécanisme le plus important pour arrêter l'hémorragie. La thrombose survenant dans ces vaisseaux est facilitée par les **facteurs de coagulation** (fibrinogène, facteurs VII, VIII, et IX) qui sont augmentés en fin de grossesse.

III. TECHNIQUE DE DELIVRANCE NORMALE

Elle commence à la phase d'expulsion

- Empaumer le fond utérin avec la main gauche,
- Le redresser pour le placer dans l'axe du bassin (il était latéro dévié)
- Exercer une pression modérée de l'utérus vers le bas.
- Se servir de l'utérus comme un piston pour propulser le placenta vers le vagin.
- Accompagner le mouvement avec la main droite en maintenant le cordon clampé sans tirer dessus
- Cesser l'expression utérine à l'apparition du placenta à la vulve
- poser la main gauche au-dessus du pubis, remonter l'utérus vers le haut pour favoriser le dépolissement du segment inférieur.

En cas d'adhérence des membranes, recueillir le placenta dans les deux mains et le vriller sur lui-même

- Si malgré ses manœuvres, les membranes se déchirent, les rattraper au bas de la vulve avec une pince et faire vriller les membranes sur elles-mêmes,
- Après la sortie totale des membranes, exprimer le fond utérin pour le vider des caillots et favoriser la rétraction utérine.

Il faut noter que le placenta sort le plus souvent par le mode Baudelocque (face fœtale qui sort la première) qui survient fréquemment si le placenta est assez haut placé. Rarement il peut sortir par le mode Duncan (face maternelle) surtout s'il est bas inséré comme dans le placenta prævia.

- ✦ **NB** : 30 minutes après l'expulsion du fœtus si le placenta n'est pas décollé il faut procéder à la délivrance artificielle.

IV. LA GATPA

La Gestion Active de la Troisième Phase de l'Accouchement (GATPA) débute juste après la naissance et permet de réduire le risque d'HPP.

Objectifs :

Accélérer le décollement placentaire

Diminuer les pertes de sang en réduisant l'hématome rétro placentaire physiologique

Favoriser la rétraction utérine afin que les vaisseaux utérins puissent se colleter rapidement

IV-1 Technique de la GATPA

La GATPA comporte trois phases qui sont :

- Administration d'utéro tonique à la patiente immédiatement après l'accouchement
- Traction contrôlée du cordon (TCC) ;
- Massage de l'utérus (si nécessaire) ;

1- Administration d'un utéro tonique

Dans la minute qui suit l'accouchement, il faut toujours palper l'abdomen de la mère pour écarter l'éventualité d'autres bébé(s) puis administrer un des utérotoniques suivant :

- Dans la minute qui suit l'accouchement, il faut toujours palper l'abdomen de la mère pour écarter l'éventualité d'autres bébé(s) puis administrer un des utéro toniques suivant :
- L'ocytocine (10 UI par voie IM/IV) est l'utéro tonique de choix. Si l'ocytocine n'est pas disponible ou sa qualité ne peut être garantie, il est possible d'utiliser l'un des utéro toniques mentionnés ci-dessous.
- La carbétocine/ carbétocine thermostable (CTS) (ampoule 100 µg par voie IM/IV). Posologies :
 - o Pour l'injection IV : 1 ml (100 microgrammes) administré lentement pendant 1 minute directement dans le port IV.
 - o Pour l'injection IM : 1 ml (100 microgrammes) par voie IM.
- Le misoprostol (400 ou 600 µg par voie sublinguale).

2- Traction contrôlée sur le cordon

- Attendre 1-3 minutes et clamber le cordon avec une pince si le nouveau-né va bien.
- Stabiliser l'utérus en exerçant une légère pression vers le haut
- Attendre une contraction de l'utérus
- Tirer très doucement sur le cordon vers le bas tout en refoulant l'utérus vers le haut
- Recueillir le placenta dans 2 mains et le déposer dans un plateau

3- Le massage utérin

- Masser immédiatement le fond utérin à travers la paroi abdominale jusqu'à ce que l'utérus se contracte.
- S'assurer que l'utérus reste bien rétracté en le palpant de temps en temps

IV-2 Gestes complémentaires à la GATPA

- Examiner le placenta
- Vérifier les voies génitales à la recherche de déchirures
- Réparer les lésions éventuelles
- Assurer une surveillance stricte dans le post-partum :
 - o Constantes : pouls, tension artérielle
 - o Globe utérin
 - o Saignement vaginal
 - o État de conscience de la parturiente

CONCLUSION

La délivrance est la dernière étape de l'accouchement. Le respect de ses différentes étapes permet d'éviter certaines complications.

Actuellement l'OMS (organisation mondiale de la santé) recommande la Gestion Active de la Troisième Phase d'Accouchement (GATPA) par la Traction Contrôlée du Cordon (TCC) qui préviendrait les risques de l'hémorragie de la délivrance.

SUITES DES COUCHES NORMALES

INTRODUCTION

Les notions sur les suites de couches normales sont importantes afin de dépister les anomalies qui peuvent intervenir dans le post-partum.

OBJECTIF GENERAL

Etre capable d'acquérir les connaissances sur les suites de couches normales.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1) Définir les suites de couches normales
- 2) Décrire les principales modifications physiologiques dans les suites de couches normales
- 3) Décrire les principaux éléments de surveillance dans les suites de couches normales
- 4) Déterminer les principaux soins à administrer dans les suites de couches normales

I. DEFINITION

Les suites de couches normales ou post partum correspondent à la période qui s'étend de l'accouchement jusqu'aux premières règles qui suivent cet accouchement.

Ces premières menstrues sont appelées retour de couches

Les suites de couches durent 45 jours soit 6 semaines après l'accouchement si la femme n'allait pas et peuvent se prolonger suivant la durée de l'allaitement.

On distingue :

- Les suites de couches immédiates (couvrant les 10 à 15 premiers jours de l'accouchement) ;
- Les suites de couches tardives (15^{ème} jour jusqu'aux retours des couches) ; Les suites de couches sont dites normales lorsque les modifications physiologiques de l'organisme se produisent sans aucune pathologie.

II. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES

Pendant la période des suites de couches plusieurs phénomènes physiologiques se produisent :

- Retour à la normale de l'organisme maternel
- Mise en place de la lactation
- Retour de la fonction hormonale

II.1 Le retour à la normale de l'organisme maternel

II.1.1 Involution utérine

C'est le retour de l'utérus à son volume et à sa forme normale. L'utérus qui occupait à terme la plus grande partie de l'abdomen doit revenir dans le petit bassin.

Aussitôt après la délivrance l'utérus se rétracte, forme un globe arrondi et dur : c'est le globe de sécurité ; garant d'une bonne hémostase.

- A J1, l'utérus est légèrement au-dessus de l'ombilic.
- A J4, il est en dessous de l'ombilic
- De J6 à J11 il est à mi-distance entre l'ombilic et la symphyse pubienne.
- De J12 à J15, il est pelvien.

Il reprend lentement sa taille normale au bout de 2 à 3 mois.

Au cours des trois jours qui suivent l'accouchement, on note une alternance de contraction et de relâchement de l'utérus appelé « les tranchées » (elles sont douloureuses et surviennent le plus souvent chez les multipares)

II.1.2 L'endomètre

Pendant l'involution utérine, l'endomètre va subir un phénomène de régénération qui se fait en quatre phases et s'accompagne d'écoulement de lochies.

- Phase de régression qui part de l'accouchement au 5^{ème} jour
- Phase de cicatrisation : du 6^{ème} au 25^{ème} jour
- Phase de prolifération qui part du 25^{ème} jour au 45^{ème} jour après l'accouchement et est favorisée par la sécrétion d'œstrogène
- Phase de reprise du cycle menstruel (le retour des couches) peut apparaître
- Vers le 45^{ème} jour si la femme n'allait pas ;
- Entre le 4^{ème} et le 6^{ème} mois si la femme allaite ;
- Vers le 30^{ème} jour si blocage de la montée laiteuse.

Le 1^{er} cycle est anovulatoire Il s'agit d'une simple hémorragie

La 1^{ère} ovulation a lieu aux environs de 40-60 j après l'accouchement

II.1.3 Les lochies

L'involution utérine s'accompagne de saignements appelés lochies. Elles proviennent de l'élimination des déchets de la muqueuse utérine et des vaisseaux qui alimentaient le placenta pendant la grossesse.

Les lochies sont :

- Sanglantes les quatre premiers jours
- Séro-sanglantes vers le 8^{ème} jour
- Séreuses vers le 15^{ème} jour avec une odeur fade.

Parfois elles deviennent sanglantes entre le 12^{ème} et le 15^{ème} jour pendant 48h : c'est le petit retour de couche.

La durée et l'abondance des lochies sont très variables d'une femme à l'autre (3 semaines à un mois). Chez certaines femmes, elles peuvent se poursuivre jusqu'au retour de couches (rares).

II.1.4 Le col utérin

Le col utérin flasque et béant, se ferme, reprends sa forme et sa longueur. L'orifice interne se rétracte et se ferme vers le 12^{ème} jour ; l'orifice externe se referme plus lentement vers le 20^{ème} jour.

II.1.5 Le Vagin et la vulve

Le vagin cicatrise rapidement. Il se rétracte en quelques jours pour retrouver des dimensions normales. La vulve restée béante après l'accouchement reprend progressivement sa forme, sa tonicité initiale ; et perd son aspect congestif. L'œdème des lèvres disparaît après 24 heures.

II.1.6 Le périnée

Le périnée, retrouve sa tonicité progressivement en fonction de la qualité de l'accouchement, de la réalisation ou non d'une épisiotomie ou de la réparation correcte des déchirures.

II.1.7. Mise en place de la lactation

Après l'accouchement, la disparition de la sécrétion placentaire de progestérone stimule la sécrétion de prolactine. Les seins sécrètent du colostrum, peu abondant mais riche en protéines.

La lactation s'installe en 24 à 48 heures : c'est la montée laiteuse. Les seins : gonflent, deviennent tendus et sensibles

La femme peut présenter une fièvre passagère à 38°C, des céphalées, des malaises et une accélération du pouls.

II.2 Retour de la fonction hormonale

- Le taux d'œstrogène s'effondre le lendemain de l'accouchement. Ce taux augmente progressivement sous l'influence de la FSH :

- A partir du 25^{ème} jour si la femme n'allait pas
- Vers les 35-45^{ème} jours en cas de lactation

- La progestérone baisse aussi pendant les 10 jours après l'accouchement. Elle disparaît pour réapparaître après la première ovulation qui peut se situer entre (le 40^{ème} et le 60^{ème} jour)

III. LES ELEMENTS DE SURVEILLANCE ET LES SOINS DANS LES SUITES DE COUCHES IMMEDIATES

III.1. Surveillance au cours de la première journée

III.1.1. Surveillance et soins pendant les 2 premières heures

Le but de la surveillance est de dépister une éventuelle hémorragie

❖ Surveillance de la mère

La surveillance de l'accouchée se fait en salle d'accouchement. Toutes les 30 mn pendant 2 heures. L'accoucheur doit surveiller et noter les paramètres suivants :

- L'état général pouls, TA, T°
- Conjonctives
- La présence d'un bon « globe utérin de sécurité » gage d'une bonne rétraction utérine.
- Ecoulement vulvaire

❖ Les Soins à la mère

- Massage et expression de l'utérus pour évacuer les caillots
- Toilette vulvaire
- Port d'une gamiture stérile ou propre
- Administrer le traitement prescrit

❖ Surveillance et soins du nouveau-né

- Examen général (coloration de la peau et des téguments, recherche de malformations)
- Désinfection des yeux
- Mensuration
- Pansement ombilical fait avec une asepsie rigoureuse
- Mise au sein en l'absence de contre-indication
- Maintien de la T° corporelle normale (chauffage)
- Vérifier l'émission du méconium
- Prévoir le B.C.G

III.1.2. Surveillance et soins après les 2 premières heures Transférer l'accouchée et son nouveau-né en suites de couches ou la surveillance (cf. les deux premières heures) se poursuivra jusqu'au lendemain.

III.1.3. Surveillance et soins les jours suivants:

La surveillance et les soins de l'accouchée doivent se faire deux fois par jour :

❖ Surveillance de la mère

- L'état général (la température, la tension artérielle, le pouls)
- Faire lever l'accouchée (prévenir la maladie thromboembolique)
- Les conjonctives.
- Seins (montée laiteuse, aider la mère à allaiter dans une bonne position détecter les anomalies du mamelon, douleur et crevasses et les traiter).
- Mollet (recherche de signes de phlébite) Les mollets doivent être souples et indolores).
- Rechercher Une crise hémorroïdaire et une fistule vaginale ou vésico vaginale.
- Involution du globe utérin (hauteur, sensibilité et consistance) elle s'apprécie par la palpation de l'utérus. L'utérus doit être ferme et indolore à la palpation. Un utérus gros, mou, et douloureux traduit une infection (endométrite), il s'apprécie en exprimant le fond utérin.

- Le périnée (la cicatrisation).
- Les lochies (abondance, aspect, odeur. L'apparition des lochies purulentes et fétides traduit une infection).
- Fonction d'évacuation vésicale et rectale
- Si mère rhésus négatif : l'injection de gammaglobulines anti D dans les 72 heures suivant la naissance si le nouveau-né est Rhésus- positif :

❖ Soins à la mère

- Administrer les traitements prescrits
- Toilette vulvaire
- En cas d'épisiotomie faire la toilette bi quotidienne ou après chaque émission d'urine et selles bien sécher le périnée appliquer le traitement et une compresse stérile et la recouvrir d'une garniture stérile ou propre.

❖ Surveillance et soins au nouveau-né

- Faire sa toilette
- Vérifier le cordon ombilical
- Vérifier l'émission de méconium et des urines
- Vérifier l'état général (coloration de la peau et des téguments)
- Vérifier les conjonctives et les yeux

IV. SUITES DE COUCHES TARDIVES

Après la période de repos observé les 15 premiers jours, suit une période d'activités modérées. Avant la sortie de l'accouchée de la maternité, la sage-femme doit lui communiquer la date du rendez-vous de la consultation post-partum qui s'effectue entre la 6^{ème} et la 8^{ème} semaine. Cette visite est obligatoire et a pour objectif :

- De confirmer le retour à la normale des voies génitales et de la fonction de reproduction, et de corriger d'éventuelles anomalies ;
- De vérifier la régression des pathologies révélées pendant la grossesse (HTA, diabète) ;
- De s'assurer de l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant ;
- De faire la CCC ;
- De proposer une éventuelle contraception et conseiller la reprise des rapports sexuels ;
- L'interrogatoire, l'examen gynécologique et l'examen médical permettront de faire le point sur l'état de santé de la mère.

CONCLUSION

La physiologie des suites de couches normales doit être connue de la sage-femme. Elle permet de mieux comprendre les anomalies de cette période importante qui suit l'accouchement.

HYGIENE DE VIE DE LA FEMME ENCEINTE

INTRODUCTION

La grossesse s'accompagne de modifications physiologiques importantes de tous les appareils. Elles surviennent spontanément et progressivement lorsqu'elles ne sont pas entravées par le comportement de la femme et par les conseils de son entourage ou même de son médecin. Ce dernier doit, au cours des entretiens pendant les consultations prénatales, exposer les nouvelles mesures d'hygiène générale et nutritionnelle qui faciliteront les adaptations de l'organisme. Ces conseils devront être raisonnables et n'entraîner que des changements modérés du mode de vie habituel de la femme.

OBJECTIFS

Objectif Général

Connaitre les éléments de l'hygiène au cours de la grossesse

Objectifs spécifiques

- 1- Connaitre l'hygiène corporelle de la femme enceinte
- 2- Savoir l'hygiène alimentaire
- 3- Décrire l'hygiène de la femme après l'accouchement

I. HYGIENE GENERALE

1- Hygiène vestimentaire

Les vêtements. – Les vêtements doivent toujours être amples, ne comprimer aucune partie du corps. Les bas à jarretière sont fortement déconseillés en raison de la stase veineuse qu'ils entraînent. Les vêtements devront être légers en période chaude et chaud en période froide.

La querelle de la ceinture de grossesse est encore d'actualité. Elle n'a pas d'utilité durant les premiers mois. Par la suite, les avis sont très partagés. En ce qui nous concerne, nous la déconseillons pour plusieurs raisons : tout d'abord parce que tout appareillage qui remplace les muscles dans leur fonction favorise leur atrophie ; or, la femme a besoin d'une bonne sangle abdominale pour maintenir sa colonne au cours de la grossesse et pour favoriser l'effet des contractions lors de l'expulsion.

Enfin, une ceinture de grossesse qui est efficace et bien serrée peut repousser l'utérus en arrière et comprimer, de façon permanente, les gros vaisseaux. Les indications de la prescription d'une ceinture abdominale ne s'imposent que chez les grandes multipares désanglées où il est nécessaire de maintenir l'utérus en place.

Soutien-gorge. – Enfin, le port d'un soutien-gorge adapté à l'augmentation du volume des seins est essentiel.

Les chaussures. – Les chaussures doivent être adaptées aux modifications de la statique qui surviennent au cours de la grossesse. En effet, la lordose lombaire s'accroît toujours. Les talons hauts risquent d'augmenter le déséquilibre statique en renforçant la lordose lombaire. Les talons plats favorisent l'affaissement de la voûte plantaire. Les chaussures doivent donc avoir des talons de hauteur moyenne et à base large.

2- L'hygiène corporelle

La douche et le bain ne sont pas contre-indiqués au cours de la grossesse. La température de l'eau dépend essentiellement des goûts personnels de la patiente. Toutefois, il est nécessaire de l'avertir que des bains très chauds peuvent entraîner une vasodilatation avec des malaises et même un état syncopal.

Les toilettes vulvaires sont identiques à celles qui précèdent la grossesse. Les injections vaginales sont déconseillées sauf prescription médicale. Toute irritation vulvaire doit entraîner un examen médical.

3- Le sommeil

La fatigue est ressentie plus rapidement et la femme enceinte a besoin de plusieurs heures supplémentaires de repos en particulier au premier trimestre. Au cours du 3^{ème} trimestre, on peut conseiller à la femme de se coucher sur le côté gauche pour éviter un syndrome de déviation par compression de la veine cave par l'utérus gravidique. L'insomnie constitue toujours un signe alarmant, car elle peut témoigner d'une anxiété très importante. La psychopathe se rencontre plus fréquemment chez les insomniennes à la fin de la grossesse. Le besoin supplémentaire de repos et de sommeil doit inciter la femme à limiter sa vie nocturne.

4- L'activité sexuelle au cours de la grossesse

La sexualité (désir, fréquence des rapports, satisfaction sexuelle) diminue du début à la fin de la grossesse. Cela pourrait être lié essentiellement à un mauvais état physique (sommolence, nausées, asthénie) ou à la crainte de léser l'œuf, puis une nette augmentation de la vie sexuelle au cours du 2^{ème} trimestre. Celle-ci lui semblait liée à un meilleur contrôle des soucis socio-économiques, à une neutralisation des craintes psychologiques et à l'amélioration des conditions anatomopathologiques. Au cours des rapports sexuels, les positions utilisées par le couple varient avec la grossesse. Pendant le premier et le deuxième trimestres, la position dite du missionnaire reste la plus fréquente, comme c'est le cas avant la grossesse. Au cours du 3^{ème} trimestre, par contre, la femme a plus souvent recours à une position dominante, côté à côté ou arrière. Les activités sexuelles substitutives (masturbation, stimulation oro-génitale) sont très fréquentes au cours de la grossesse, particulièrement au cours du 3^{ème} trimestre. Elles ont un retentissement favorable sur le couple surtout lorsque la femme est psychologiquement équilibrée. Les rêves érotiques ont également un caractère compensatoire.

5- Les sports

Les sports entraînant des secousses ou des trépidations doivent être également évités par le risque de contractions utérines qu'ils peuvent déclencher (cheval, ski de neige et ski nautique, tennis, etc.). A cela s'ajoute une certaine réticence pour les sports qui nécessitent une tension musculaire et l'ligamentaire importante. En effet, l'imbibition gravidique par l'œdème des muscles et la laxité ligamentaire qu'elle entraîne est la cause possible d'accidents notamment dans la pratique du ski ou de l'alpinisme. Enfin, paraissent contre-indiqués tous les sports qui peuvent faciliter les traumatismes directs et indirects de l'utérus comme la lutte et le plongeon. En dehors de ces cas particuliers, un minimum d'efforts physiques paraît tolérable et même utile pour le bon déroulement de la grossesse. Ils permettent, en particulier, d'activer le débit circulatoire, d'augmenter l'oxygénation de l'unité fœto-placentaire et de faciliter la circulation de retour. Parmi ces activités, la marche, la natation en piscine chauffée, la bicyclette, faites régulièrement sans esprit de compétition ne peuvent être que bénéfiques, assurément, outre la souplesse, la conservation ou même de développement d'une bonne musculature de la sangle abdominale, des masses musculaires lombaires et pévipériénales. En conclusion, une activité musculaire régulière et non excessive est souhaitable pendant la grossesse assurant souplesse et musculature suffisantes.

6- Les voyages

Le problème du risque que comporte éventuellement le recours à un moyen de transport est fréquemment discuté au cours de la grossesse. On admet généralement que la femme enceinte peut voyager sans danger pour elle et son fœtus ; cependant, en cas de complications gravidiques, le voyage peut, s'il est quelque peu important, n'être pas exempt de risques. Le cyclomoteur. — Il est très inconfortable et favorise les chutes par modification du centre de gravité qui compromettent l'équilibre. La moindre aisance de la femme enceinte augmente la fréquence des chutes. C'est la raison pour laquelle ce moyen de locomotion est déconseillé. L'automobile. — C'est le moyen de transport le plus utilisé. Il est à l'origine de secousses, de stress en cas de circulation intense et de « congestion pelvienne » qui résulte du maintien de la position assise pendant une longue durée lorsque les voyages sont longs.

En 1967, déjà, l'Association des Médecins Américains avait prôné l'obligation de porter la ceinture de sécurité

pour tous les automobilistes, y compris pour les femmes enceintes. Elle donna la préférence à la ceinture à 3 points de fixation avec une sangle fixée à hauteur des hanches. En effet, en cas de collision frontale quand la femme est maintenue par une ceinture à 2 points de fixation au niveau du bassin, le tronc est projeté en avant et continue à se fléchir vers l'avant jusqu'à ce que la flexion du corps sur les cuisses soit complète. Pendant ce temps, la ceinture exerce sur l'abdomen une pression qui se répercute à l'intérieur de l'utérus.

L'aviation. — On peut donc affirmer que la diminution de la PO_2 que l'on trouve dans les avions ne peut avoir aucun effet défavorable sur le fœtus à condition qu'il n'y ait aucune autre pathologie susceptible d'aggraver l'anoxie fœtale comme, par exemple, une hémoglobiopathie SS. En ce qui concerne les accélérations et les vibrations, on estime qu'elles ne sont certainement pas plus importantes que celles rencontrées dans la vie courante (ascenseur, freinage en voiture, etc.). La question de l'accélération au décollage, par contre, n'a, à ce jour, pas encore été étudiée. Les radiations ionisantes sont sensiblement les mêmes dans un avion en vol que celles enregistrées au niveau de la mer. Il n'y aurait donc pas lieu de craindre des effets tératogènes.

Les voyages lointains en avion entraînent souvent la nécessité de vaccinations qui ne sont pas toujours compatibles avec la grossesse et souvent la prise d'anti-paludéens. Les compagnies aériennes acceptent les femmes enceintes jusqu'à la fin du 8^{ème} mois de la grossesse. Des exceptions peuvent être admises au cours du dernier mois en cas d'urgence. Il existe dans l'appareil une trousses permettant un accouchement et, au cours de leur formation, les hôtes de l'air reçoivent quelques notions sommaires d'obstétrique.

Le train. — Il est préférable à la voiture, la femme pouvant changer de position au cours du voyage. Il faut conseiller à une femme enceinte circulant sur un long trajet en train, de prendre place dans un wagon-couchettes le plus loin possible des roues afin d'éviter au maximum les chocs intempestifs. Le bateau. — Il n'y a pas d'inconvénient important à le prendre si ce n'est le risque d'être loin de tout secours médical et de présenter des troubles digestifs en rapport avec le mal de mer. S'il faut être assez libéral en matière d'autorisation de voyage, il faut toutefois connaître quelques interdictions : celles liées à une évolution anormale de la grossesse ou à des antécédents obstétricaux défavorables comme des interruptions précoces ou tardives ; celles liées à la proximité du terme ou au lieu de séjour qui peut être dépourvu de ressources obstétricales et chirurgicales.

7- Le tabac

Il est bien connu depuis longtemps que l'intoxication tabagique chez la femme enceinte entraîne un retard de croissance intra-utérin. Le taux de mortalité ou de mortalité néonatale précoce augmente. Il existe une relation cause-effet puisque la diminution du poids de naissance est en relation directe avec le nombre de cigarettes fumées. Il est de règle de conseiller aux femmes d'arrêter de fumer dès le début de la grossesse ou si possible quelques mois auparavant.

8- Les autres intoxications maternelles non alimentaires

Les vernis, les peintures et les hydrocarbures sont riches en benzène, plomb, arsenic, cadmium, mercure, zinc, manganèse et cobalt. Les peintures industrielles semblent plus dangereuses que les peintures à usage domestique. Les métaux lourds sont capables d'induire des dommages du système vasculaire, des reins et des organes hématopoïétiques. Le plomb est responsable d'avortements et de mortalité. Il faut toutefois conseiller aux femmes enceintes de ne pas utiliser ces produits et, si des travaux de peinture doivent être faits dans leur appartement, il est nécessaire d'y assurer une excellente ventilation et de ne rester dans les pièces fraîchement peintes que pendant des temps très courts. L'oxyde de carbone dissous dans le plasma maternel franchit le placenta vers le fœtus, les lésions cérébrales dues à l'anoxie chronique sont très fréquentes même par les hématies. Chez le fœtus, les lésions cérébrales dues à l'anoxie chronique sont très fréquentes même lorsque la mère guérit sans séquelles neurologiques d'une intoxication oxygénée.

9- L'hygiène mentale

Il est important que le médecin soit conscient des conditions générales de vie de la femme enceinte qu'il suit et notamment des soucis de sa vie quotidienne. Par ailleurs, face à l'angoisse naissante de l'inconnu, il doit veiller à préparer consciencieusement sa cliente par un enseignement psychoprophylactique soigneux dès le début de la grossesse.

II/ TRAVAIL ET GROSSESSE

1- La durée du travail

Il arrive que pour diverses raisons les congés prénataux soient détournés de leur raison d'être. En effet, certains organismes, et il se trouve que ce sont surtout des organismes d'Etat (fonction publique ou entreprise nationalisée), qui donnent la possibilité aux femmes enceintes de cumuler le congé prénatal et le congé post-natal avec la complicité du médecin qui doit délivrer un certificat. Cette pratique détourne l'esprit de la loi qui est de protéger la grossesse et le fœtus. Il est important que le médecin n'autorise pas cette pratique car il serait responsable si, dans conditions, un accouchement prématuré se produisait avec handicap ou mort de l'enfant.

N.B. : En Côte d'Ivoire la loi donne droit à la femme un congé prénatal et post-natal de 6 mois au total (dont 8 semaines avant la date théorique d'accouchement et 16 semaines après cette date). Le début du congé prénatal se situe entre 32 et 34 semaines d'aménorrhée (7 mois ½ de grossesse).

La qualité du travail. – La « pénibilité » d'un travail est très difficilement appréciable notamment de la part de femmes enceintes qui ne gardent plus le même intérêt pour leur activité, préoccupées qu'elles sont de leur grossesse. Il est certain (et quelques entreprises fort heureusement le font) que la femme enceinte devrait pouvoir bénéficier de changements de poste, de possibilités de station assise quand elle en ressent le besoin, voire même de réductions d'horaires.

La position de la femme intervient notablement surtout les travaux des bras au-dessus des épaules, station debout prolongée, position très courbée ou agenouillée. Malheureusement, dans le calcul des indices, le changement de position et les efforts de transport de charges ne sont pas toujours pris en considération.

Les professions les plus exposées semblent être :

- Celles qui exigent un travail debout et surtout la station debout immobile (hôtesse) ;
- Le piétinement et le changement très fréquent de position (laborantines, chaînes d'automobiles, commerçantes) ;
- Les charges lourdes et les diverses manutentions (manutentionnaires, magasiniers) ;
- L'absence de pause ou une seule pause dans la journée ;
- L'importance de la charge de travail, notamment pour le personnel paramédical (le nombre de malades par agent) ;
- Le travail sur machines trépidantes ainsi que les vibrations de faible fréquence.

Les employées de bureau semblent être privilégiées à la fois dans la qualité de la surveillance prénatale et dans l'issue de la grossesse.

2- L'environnement

En cas de survenue de complications (menace de fausse couche, menace d'accouchement prématuré, apparition d'un retard de croissance intra-utérin) il ne devra pas hésiter à prescrire un arrêt de travail à condition que celui-ci n'augmente pas les tâches ménagères de la patiente mais, au contraire, lui permette d'avoir un repos efficace pour le bien-être de son fœtus.

III/ HYGIENE ALIMENTAIRE

1- Les besoins qualitatifs

Les besoins en protéines. – Il faut donc recommander 1,3g de protéines par kg chez la femme enceinte adulte, 1,5g de protéines par kg chez l'adolescente qui est enceinte, et s'il s'agit d'une femme encore plus jeune (en dessous de 15 ans), 1,7g de protéines par kg. Ce sont là les normes conseillées aux Etats-Unis.

Les besoins en fer et en acide folique. – Ils ont été largement traités par ailleurs. Rappelons seulement qu'en raison des besoins de fer chez la femme enceinte, l'apport supplémentaire par voie orale de 30 à 60 mg par jour est unanimement admis.

Les vitamines. – Les vitamines essentielles (A, B, C, D, E, K) sont contenues dans un menu alimentaire bien équilibré. Elles sont indispensables puisqu'elles constituent la base des différents systèmes enzymatiques.

N.B. : Le surdosage en vitamine A doit être évité en raison de son risque tératogène possible

Le sel. – Le régime sans sel est dangereux chez la femme enceinte normale parce qu'il déséquilibre la balance sodée de l'organisme.

2- Le régime équilibré de la femme enceinte

La diversité est essentielle à un régime alimentaire bien équilibré. Il y a 5 groupes majeurs d'aliments : le lait, la viande et ses substituts, le pain ou ses substituts, les fruits et les légumes. Du point de vue de la valeur nutritive un groupe ne peut être remplacé par un autre. Tous sont aussi importants par leurs différentes fonctions à l'intérieur de l'organisme.

Le lait. – C'est une excellente source de protéines, de calcium, de vitamines D, A, et de riboflavine. Il est énergétique et a un très bon effet de satiété. Aussi, il faut recommander l'absorption de 500 ml à 1 litre de lait par jour au cours ou entre les repas.

Viandes, poissons, volailles, œufs, fromages. – Tous sont d'excellentes sources de protéines et de vitamines liposolubles ainsi que de vitamine B. Ils contiennent des acides gras essentiels et les protéines que l'on retrouve dans ces aliments fournissent les acides aminés habituellement utilisés par l'organisme pour construire de nouveaux tissus. On peut recommander une portion de viande, de fromage ou des œufs au déjeuner ou au dîner. Le foie, les rognons, les abats et le cœur sont également une bonne source de fer. Ils devraient apparaître au menu une à deux fois par semaine.

Les féculents, pain, pommes de terre, pâtes, céréales, riz. – Ce sont des aliments énergétiques, contenant des hydrates de carbone d'absorption lente. Ils représentent une très faible source de protéines. Ils doivent apparaître régulièrement lors des menus.

Fruits et jus de fruits. – Ils contiennent des vitamines hydrosolubles et en particulier de la vitamine C. Ils sont riches en hydrates de carbone à absorption rapide et c'est la raison pour laquelle ils devraient être conseillés comme dessert. Par ailleurs, ils entraînent une quantité importante de résidus qui, par leur volume, régularisent le transit. Ils sont essentiels à un régime bien équilibré.

Les légumes et leur jus. – Ils sont riches en vitamines hydrosolubles et en vitamine A. La plupart sont peu énergétiques et contiennent peu de protéines. Par contre, ils sont essentiels dans l'apport de minéraux. Leur contenu en cellulose aide à lutter contre la constipation. Il est nécessaire qu'une partie de ces légumes, notamment des légumes verts, soit consommée à l'état cru.

Les corps gras. – Ils ne forment pas à eux seuls un groupe alimentaire. Ils servent surtout à accompagner les aliments : le beurre, la margarine, les huiles, les crèmes etc. Ils représentent de très faibles sources de protéines et sont très caloriques. Ils doivent être pris avec discernement.

3- Café et grossesse

Elles incitent toutefois à la prudence et il semble légitime de déconseiller une surconsommation de café au cours de la grossesse.

4- Alcool et grossesse

Si la mère boit et fume et, de plus inhale la fumée, le risque s'additionne et peut devenir neuf fois plus grand que le risque encouru par une femme qui ne fume pas et ne boit pas. Dans l'enquête française, plus de la moitié des cas d'hématomes rétro-placentaires était due à des consommations exagérées de tabac et/ou d'alcool.

5- Hygiène buccale de la femme enceinte

Aussi l'hygiène buccale est-elle essentielle au cours de la grossesse. Il est nécessaire de supprimer tous les facteurs locaux irritatifs, comme les plaques dentaires, par brossage vertical des dents et des gencives avec une brosse très souple ; l'usage d'un hydropropulseur après le brossage, le soir notamment, le traitement des caries et un détartrage éventuel doivent être préconisés.

Il est fréquent que la femme enceinte demande à son médecin s'il est possible de se faire traiter des caries dentaires. Il faut l'encourager à voir son dentiste pour ces thérapeutiques en la prévenant toutefois que les séances sur un fauteuil dentaire doivent être brèves pour éviter un syndrome de décubitus, que les anesthésiques locaux peuvent être utilisés à condition qu'ils ne soient pas associés à des solutions adrénalinées à des doses relativement fortement concentrées, enfin que certains antibiotiques sont déconseillés dans son état. Les radiographies dentaires ne sont pas interdites à condition d'utiliser un tablier de plomb et de ne pratiquer que les clichés indispensables.

IV/ HYGIENE DU POST-PARTUM

1- Hygiène générale

Quelques points particuliers sont à souligner :

- La rééducation musculaire abdominale et périnéale doit être entreprise très tôt pour restaurer la sangle abdominale et la tonicité des releveurs ;
- Les soins périnéaux doivent parfois être poursuivis après la sortie de l'hôpital ;
- Les seins chez la femme qui allaite doivent être bien soutenus et l'état des mamelons particulièrement entretenu : lavage à l'eau propre après les tétées, assèchement et protection par tissu propre jusqu'à la tétée suivante ;
- Les rapports sexuels ne sont en général repris qu'après le retour de couches ; la femme peut alors avoir recours à la contraception.

2- Hygiène alimentaire

L'allaitement exige un apport supplémentaire en calories. On considère qu'il faut environ 900 kcal pour la production d'un litre de lait. Si l'on tient compte des réserves de graisses qui ont été accumulées pendant la grossesse et qui peuvent servir d'apport énergétique, un appoint supplémentaire de 500 kcal par jour est suffisant pendant les trois premiers mois. Les aliments doivent apporter des quantités suffisantes en protéines, en glucides, lipides, vitamines. Les besoins en calcium sont assurés par l'absorption d'un quart à un demi-litre de lait.

Le tabac est déconseillé chez la femme qui allaite en raison du passage de la nicotine dans le lait.

CONCLUSION

La femme enceinte a besoin d'une bonne hygiène générale, alimentaire et autres afin de bien mener à terme sa grossesse et d'éviter la survenue de complication. La sage-femme dans sa pratique doit éduquer et accompagner les gestantes afin de leur garantir un bon équilibre au cours de la grossesse.

LES ANNEXES DU FŒTUS

INTRODUCTION

L'œuf constitué comprend d'une part le fœtus lui-même et d'autre part les annexes du fœtus.

Les annexes du fœtus sont des formations temporaires destinées à protéger, nourrir, oxygéner l'embryon, puis le fœtus durant la vie intra-utérine.

Les annexes du fœtus comprennent : le placenta, les membranes de l'œuf, le liquide amniotique et le cordon ombilical.

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les différentes annexes du fœtus

OBJECTIF SPECIFIQUES

- 1-Définir les annexes fœtales
- 2-Enumérer 4 fonctions du placenta
- 3-Décrire les éléments constitutifs des membranes amniotiques
- 4-Citer les sources du liquide amniotique
- 5-Préciser le rôle du liquide amniotique

I. PLACENTA

1- FORMATION DU PLACENTA

Simultanément, pendant que la nidation débute au 7^{ème} jour de la fécondation, le trophoblaste se développe très rapidement et va commencer à se différencier en syncytio-trophoblaste et en cytotrophoblaste : c'est alors le début de la formation du placenta proprement dite.

- Début de la placentation

La placentation commence le 7^{ème} jour de grossesse (7^{ème} de fécondation).

- Fin de la placentation

La période de la placentation se termine à la fin du 4^{ème} mois de grossesse

2- COMPOSITION DU PLACENTA

Le placenta est composé de deux sortes d'élément :

- *les éléments d'origine ovulaire représentés par les villosités placentaires.
- *les éléments d'origine maternelle représentés par les caduques utérines

L'embryon pénètre dans l'endomètre durant la nidation en émettant des proliférations pseudopodiales encore appelées villosités qui érodent la muqueuse utérine gorgée de sang maternel.

Vers le 23^{ème} jour de la fécondation si cycle menstruel de 28 jours ($J_{14} + 23 = J_{37}$)

Le cœur de l'embryon commence à battre au 23^{ème} de vie.

Il s'établit alors une véritable circulation sanguine embryo-placentaire.

Dès l'implantation de l'œuf, la muqueuse utérine se transforme en caduque ou déciduale.

La décidualisation se fait surtout dans la zone superficielle de la muqueuse utérine (où les glandes disparaissent entièrement). Cette zone superficielle porte le nom de couche compacte.

3-MORPHOLOGIE DU PLACENTA A TERME

- **Forme** : Le placenta est un disque d'environ 16 à 20 cm de diamètre.

- **Poids pendant la délivrance à terme**. Le poids du placenta égale au 1/6 du poids du fœtus.

Ainsi le placenta pèse environ 500g – 600g.

Au début de la grossesse, le volume du placenta est supérieur à celui du fœtus.

- **Faces** : il y a 2 faces : **face fœtale** – **face maternelle**

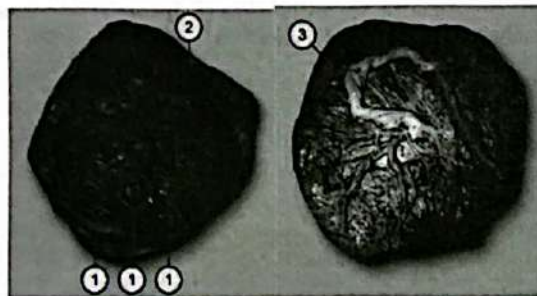
***Face fœtale** : elle est lisse. Cette face est en contact de la cavité amniotique, elle est appelée plaque chorale. Cette plaque est tapissée en dedans par l'amnios. Le cordon ombilical s'insère sur cette face fœtale.

***Face maternelle** est charnue, elle est constituée par la **caduque basilaire**.

Débarrassée du sang qui la recouvre, cette face maternelle est parcourue par des sillons qui délimitent des **cotylédons**.

A la périphérie, le placenta se continue avec les membranes qui sont constituées par l'accolement de : l'amnios, chorion, et des caduques réfléchie et pariétale.

1	Cotylédon	3	cordons ombilical
2	bord libre de l'amnios sectionné	4	caduque avec la couche compacte après décollement du placenta



4. PHYSIOLOGIE DU PLACENTA

Le placenta joue plusieurs rôles :

- Organe d'échange entre la mère et le fœtus, assurant sa respiration et sa nutrition.

- Activité métabolique et endocrine qui assure l'équilibre hormonal de la grossesse.

- Le placenta produit de **grandes quantités d'hormones** :

***La progestérone**, les **œstrogènes**, prenant le relais du corps jaune après la 11^{ème} semaine de grossesse.

***L'hormone chorionique gonadotrope (H.C.G.)** au cours des deux premiers mois de grossesse permettant de supporter l'activité sécrétoire du corps jaune. **La présence le HCG dans les urines ou dans le plasma est à la base de tests de grossesse.**

• **L'Hormone Lactogène Placentaire (HPL)** et d'autres hormones protéiques.

• **Les Prostaglandines** qui jouent un rôle dans la poursuite de la grossesse et dans le début du travail.

- **Rôle protecteur du placenta**

Il le protège contre les agressions bactériennes, parasitaires et toxiques et régit le passage de certaines substances médicamenteuses.

II- LES MEMBRANES DE L'ŒUF

1. COMPOSITION

Au nombre de deux : le **chorion** en dehors, l'**amnios** en dedans. Elles contiennent le fœtus et le liquide amniotique et empêchent le fœtus d'être en contact avec l'extérieur à travers l'orifice du col.

1-1. Le chorion

C'est une membrane située **entre la caduque utérine et l'amnios**. Elle est fibreuse, transparente et résistante. Elle adhère à la caduque et se sépare facilement de l'amnios.

À l'orifice interne du col, le chorion est **directement en rapport avec le bouchon muqueux**.

1-2. L'amnios

C'est une membrane mince, transparente, très résistante et qui **circonscriit en dedans la cavité amniotique**. Elle **tapisse la face fœtale du placenta**, engaine le cordon et rejoint à l'ombilic la peau du fœtus.

Sa face externe est accolée au chorion et s'en détache facilement.

III- LE LIQUIDE AMNIOTIQUE(L.A.)

1. Généralités

Normalement, le liquide amniotique est un liquide clair et transparent, blanchâtre vers la fin de la grossesse ; son odeur est fade. Son pH est faiblement alcalin, compris entre : 6,90 et 7,20

Son volume est compris entre 500 ml et 1 litre en moyenne à terme.

2. Composition

Sa composition est très semblable au plasma sanguin, Il est composé :

- **d'eau** : 98,4 à 99,4% ;
- **de sels minéraux** : 0,71% ;
- **de substance organique** : 0,25% ;
- **glucose** : 0,50g/l au début de la grossesse à 0,20g/l en fin de grossesse ;
- **lipides** : 50mg/100ml ;

3. Origine de la sécrétion du liquide amniotique

Elle est surtout **fœtale** ;

- Origine fœtale : **urines du fœtus** surtout après la 16^{ème} semaine
- Origine amniotique : l'**amnios** ; - d'**origine maternelle** par transsudation de liquide.

4. Résorption du liquide amniotique :

Cette résorption se réalise selon trois mécanismes :

- Par **déglutition** du liquide amniotique par le fœtus (environ 500ml/24heures) ;
- Par **exsudation** à travers la membrane ;
- **Réabsorption** par l'**épithélium amniotique**

Il s'établit un équilibre entre la production et la résorption du liquide, pour maintenir son volume constant.

5. Rôle physiologique.

Il est différent pendant la grossesse et pendant l'accouchement.

➤ PENDANT LA GROSSESSE

- Assure l'hydratation du fœtus ; - apport quotidien d'eau et de sels minéraux ;
- Permet le développement du fœtus et ses déplacements ;
- Réalise l'isolement thermique du fœtus ;
- Facilite l'accommodation de la présentation ;
- Protège le fœtus contre les traumatismes extérieurs, la compression du cordon ombilical et les infections

➤ PENDANT L'ACCOUCHEMENT

- Continue à protéger contre l'infection et le traumatisme,
- Concourt à la formation de la poche des eaux,
- Lubrifie la filière génitale après la rupture des membranes,
- Facilite la progression de la présentation.

IV- LE CORDON OMBILICAL

C'est une tige conjonctivo-vasculaire engainée par l'amnios, reliant le fœtus au placenta.

À terme, c'est une tige arrondie, turgescence, tordue en spirale, blanchâtre et luisante.

Sa longueur varie d'un sujet à l'autre : 50 cm environ en moyenne (50 ± 15 cm).

L'épaisseur du cordon est variable, égale à 1,5 cm en moyenne. Il peut être anormalement gros ou grêle.

Le cordon s'insère sur la face fœtale du placenta habituellement au milieu de la surface placentaire ; cette insertion normale est dite centrale.

La surface du cordon n'est pas lisse ; elle est parsemée de nodosités irrégulières.

Il contient 3 vaisseaux : deux artères et une veine.

Les battements du cordon ombilical sont isochrones au pouls fœtal. Le cordon ne contient pas de nerf.

CONCLUSION

Les annexes du fœtus sont indispensables à sa survie. Une anomalie des annexes du fœtus lui sont préjudiciables, pouvant entraîner son décès.

ADMISSION DE LA PARTURIENTE EN SALLE DE TRAVAIL

INTRODUCTION

L'accueil et l'examen de la gestante dès son admission en salle d'accouchement sont des étapes capitales de la prise en charge du travail. Les premiers gestes qui seront réalisés par la sage-femme peuvent conditionner le pronostic de l'accouchement.

OBJECTIF GENERAL

Etre capable d'appréhender les étapes de l'admission de la parturiente en salle de travail.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Décrire tous les éléments de l'accueil en salle de travail ;

Décrire toutes les étapes de l'examen d'entrée en salle de travail.

I- ACCUEIL

L'accueil consiste à :

- Saluer affectueusement la parturiente
- Se présenter à elle
- L'identifier
- L'installer confortablement en décubitus latéral gauche
- L'informer des gestes à faire
- Exploiter le carnet de santé ou le dossier si elle en possède
- La préparer psychologiquement

Tout cela doit se faire dans une atmosphère détendue, dans un climat de confiance afin de faciliter l'examen d'entrée.

II- EXAMEN D'ENTREE

Il doit être précis et rapide et ne doit ignorer aucun aspect.

II-1- Le but

Il permet de regrouper un ensemble de données par l'interrogatoire, les examens cliniques, les examens complémentaires en fonction desquels on prendra une décision.

L'attitude que la sage-femme doit adopter est différente selon qu'elle soit devant une urgence ou non.

II-2- L'interrogatoire ou anamnèse

- La sage-femme doit noter l'heure et la date d'entrée de la parturiente.
- Demander son carnet de santé mère enfant, vérifier l'identité et tous les renseignements en rapport avec la parturiente (Nom, prénom(s), âge, gestité, parité), conditions socio-économiques, les antécédents médicaux, gynécologiques et obstétricaux, renseignements sur la grossesse actuelle, son âge, son terme et son suivi).
- Elle doit s'informer sur le motif d'entrée en salle de travail :
 - Contractions utérines ;
 - Perte des eaux, si pertes des eaux noter la date, l'heure, l'abondance, la coloration et l'odeur ;
 - Des saignements ;
 - Fièvre ;
 - L'existence ou non des mouvements actifs du fœtus.

II-3- Examen clinique

II-3-1-Examen général

Peser (calculer la prise de poids total pendant la grossesse (12kg au plus) ;
Mesurer de la taille (si la taille < 1,50 m Bassin rétréci probable) ;
Apprécier son état général ;
Vérifier sa démarche pour déceler une boiterie, une déformation de sa colonne vertébrale (apprécier le losange de Mikaelis) ;
Recueillir les urines à la recherche de l'albumine et du sucre ;
Installer la parturiente sur une table propre ;
Prendre la tension artérielle, le pouls et la température ;
Vérifier si la femme a été groupée sinon prélever le sang pour le groupe sanguin rhésus ;
Noter ces résultats dans le dossier ou le registre d'accouchement.

II-3-2- Inspection

Elle doit se faire dans l'ordre chronologique. Elle recherche au niveau :
Du visage : des œdèmes ;
Des conjonctives : une pâleur ou un ictère ;
De la bouche : une carie dentaire, une langue saburrale, un herpès labial, etc.
Du cou : des ganglions, une hyperthyroïdie (goitre) ;
Des seins : un nodule, une malformation ou une éventuelle sécrétion en pressant le mamelon ;
De l'abdomen : la forme de l'utérus et son grand axe, une cicatrice abdominale et la cause, la présence de vergetures ;
De la vulve : une excision, des varices, des œdèmes, un écoulement ; des condylomes (crête de coq) ;
Des membres inférieurs : les varices au niveau de la face interne de la cuisse, les œdèmes au niveau des malléoles, du dos du pied et de la face externe.

II-3-3- Examen obstétrical

Installer (position gynécologique).

Mesurer la **hauteur utérine** (normale 32 cm-34 cm)

- Si la **hauteur utérine supérieure à la normale** il faut rechercher :
Un gros fœtus
Une grossesse multiple
Un hydramnios.
- Si la **hauteur utérine est inférieure à la normale**, il faut rechercher :
Une erreur de terme,
Une menace d'accouchement prématuré
Une hypotrophie fœtale.

Mesurer le **périmètre abdominal** passant par l'ombilic.

Faire le **palper abdominal** à la recherche :

- De la présentation (céphalique, siège, transversale)
- Du niveau de la présentation (haute et mobile, amorcée, fixée, engagée)
- La position du dos par la manœuvre de Budin

Auscultier et chronométrer les bruits du cœur fœtal, qui doivent être réguliers, ≥ 120 et ≤ 160 battements par minute.

Faire le **toucher vaginal** pour :

- Apprécier le col (sa position, sa longueur, sa consistance, et sa perméabilité)
- Le segment inférieur (formé ou mal formé)
- Confirmer la présentation,
- Apprécier la poche des eaux ; elle peut être intacte (plate ou bombante), ou rompue.

NB : Si elle est rompue, demander impérativement la date et l'heure de la rupture. Si la durée de la rupture est supérieure ou égale à 06 heures, faire systématiquement une antibiothérapie.

Vérifier l'aspect du liquide amniotique, sa couleur, son abondance, son odeur.

Examiner le bassin :

- Essayer d'atteindre le promontoire
- Suivre les lignes innommées

Au niveau de l'excavation :

- Apprécier la concavité sacrée qui normalement est profonde et régulière
- Rechercher les épines sciatiques latéralement : normalement elles sont non saillantes.

Au niveau du détroit inférieur

- Apprécier l'ogive pubienne
- Apprécier la souplesse du périnée

Au terme de cet examen minutieux et en absence de souffrance fœtale, la sage-femme doit surveiller le travail à l'aide d'un partographe.

Dans ce cas :

- Administrer un lavement évacuateur si elle est en début de travail
- Raser la vulve (jamais le mont de venus)
- Faire la toilette vulvaire avec un antiseptique et de l'eau tiède
- Porter à la parturiente une garniture propre ou stérile.

EN CAS D'URGENCE

La sage-femme doit :

- Noter l'heure et la date d'entrée de la parturiente
- Déterminer l'urgence (hémorragie, procidence du cordon, éclampsie)

Le pronostic maternel et/ou fœtal étant en jeu la sage-femme doit contrôler dès l'entrée en salle de travail les constantes de la mère et apprécier immédiatement l'état du fœtus (BDCF et MAF). Si le fœtus est encore vivant l'extraire de l'utérus est une urgence, alors la césarienne s'impose.

La sage-femme doit préparer la parturiente (préparation psychologique, raser, grouper, faire le bilan d'hémostase (TP, TCK, NFS).

CONCLUSION

Durant la période de travail, la femme vit de grands bouleversements pouvant se traduire par des attitudes agressives parfois infantiles. La sage-femme doit donc sécuriser la future mère, la soutenir à tout point de vue. Une mauvaise attitude peut entraîner chez la parturiente une méfiance, une crispation, une absence de coopération lors de l'examen d'entrée voire de l'accouchement.